

Bunga Rampai **ISU DAN PRAKTIK KESEHATAN TERKINI** DALAM PERSPEKTIF TENAGA KESEHATAN

Halimatussakdiah • Septiwiarsi • Anita Setyawati • Yanti

Editor : Andriya syahriyatul masrifah



BUNGA RAMPAI: ISU DAN PRAKTIK KESEHATAN TERKINI DALAM PERSPEKTIF TENAGA KESEHATAN

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat

Bdn. Septiwiarsi, SST., M.Kes

Anita Setyawati, S.Kep., Ners., M.Kep.

Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.

Editor:

Andriya syahriyatul masrifah S.ST., M.Kes., M.Keb.

Bunga Rampai: Isu Dan Praktik Kesehatan Terkini Dalam Perspektif Tenaga Kesehatan

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat
Bdn. Septiwiarsi, SST., M.Kes
Anita Setyawati, S.Kep., Ners., M.Kep.
Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb.

Editor:

Andriya syahriyatul masrifah S.ST., M.Kes., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-74-5

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bunga rampai berjudul *"Isu dan Praktik Kesehatan Terkini dalam Perspektif Tenaga Kesehatan"* ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai wujud kontribusi pemikiran akademik dan praktik profesional dalam merespons dinamika serta tantangan kesehatan yang terus berkembang di Indonesia.

Perubahan sosial, demografi, epidemiologi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan berbagai isu kesehatan masyarakat yang kompleks. Indonesia saat ini menghadapi tantangan ganda, mulai dari penyakit menular dan tidak menular, permasalahan gizi, kesehatan lingkungan, hingga kesenjangan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif terhadap isu kesehatan masyarakat menjadi landasan penting dalam merancang intervensi yang efektif dan berkelanjutan.

Kesehatan ibu dan anak tetap menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional. Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal memerlukan peran aktif seluruh tenaga kesehatan. Pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan pelayanan kuratif dan rehabilitatif menjadi kunci dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan semakin strategis. Tenaga kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai edukator, advokat, dan agen perubahan di masyarakat. Literasi kesehatan yang baik akan mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatannya secara mandiri.

Selain kompetensi teknis, aspek etika dan profesionalisme menjadi fondasi utama dalam praktik pelayanan kesehatan. Integritas, tanggung jawab, empati, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi merupakan nilai-nilai yang harus senantiasa dijunjung tinggi. Profesionalisme yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjamin mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Bunga rampai ini menghimpun gagasan, kajian ilmiah, dan pengalaman praktik dari berbagai perspektif tenaga kesehatan. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi akademik sekaligus sumber inspirasi bagi mahasiswa, praktisi, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat peran tenaga kesehatan menghadapi isu dan praktik kesehatan terkini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini memberikan manfaat luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 ISU KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA SAAT INI..... 1

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan Penulisan buku.....	2
C. Transisi Epidemiologi	4
D. Isu Penyakit Menular Prioritas di Indonesia.....	8
E. Masalah Penyakit Tidak Menular (PTM)	12
F. Masalah Kesehatan Ibu, Anak, Dan Remaja	15
G. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan	18
H. Simpulan	19
I. Referensi	19

CHAPTER 2 KESEHATAN IBU DAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN.....24

Bdn. Septiwiarsi, SST., M.Kes	24
A. Pendahuluan/Prolog.....	24
B. Konsep Dasar Kesehatan Ibu dan Anak.....	25
C. Kondisi Umum Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia	33
D. Kualitas Pelayanan dan Pusat pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.....	34
E. Upaya Meningkatkan kelangsungan Hidup ibu dan Anak	36
F. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan	37
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pembangunan KIA.....	37
H. Simpulan	38
I. Referensi	39
J. Glosarium.....	40

CHAPTER 3 PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN42

Anita Setyawati, S.Kep., Ners., M.Kep	42
A. Pendahuluan.....	42
B. Landasan Konseptual dan Teoretis Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan	43
C. Pendidikan Kesehatan Klinis dan Pemberdayaan Pasien	46
D. Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas dan Praktik Perawatan Primer	50

E. Promosi Kesehatan di Tempat Kerja dan Organisasi	54
F. Inovasi Digital, Pertimbangan Etika, dan Arah Masa Depan	57
G. Simpulan	61
H. Referensi	62

CHAPTER 4 ETIKA DAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN..... 63

Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb	63
A. Pendahuluan.....	63
B. Etika Profesi dalam Konteks Pelayanan Kesehatan	66
C. Prinsip-Prinsip Etika Kesehatan sebagai Landasan Praktik Profesional	67
D. Profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Berpusat pada Pasien	68
E. Etika Profesi sebagai Fondasi Profesionalisme Tenaga Kesehatan.....	69
F. Penguatan Etika Profesi dalam Pendidikan dan Praktik Kesehatan	70
G. Kesimpulan.....	72
H. Referensi	73
I. Glosarium.....	74

PROFIL PENULIS 75

CHAPTER 1

ISU KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA SAAT INI

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan

Fenomena kesehatan masyarakat Indonesia saat ini mencerminkan dinamika pembangunan yang kompleks, ditandai oleh capaian penting sekaligus tantangan berkelanjutan pada beberapa isu penyakit. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2023 bahwa, rujukan utama untuk memahami lanskap kesehatan nasional melalui indikator kesehatan, demografi, serta program prioritas pelayanan kesehatan di tingkat nasional dan daerah baik di Provinsi maupun di kabupaten kota. Meskipun terjadi peningkatan akses layanan dan angka harapan hidup, namun berbagai masalah seperti beban ganda penyakit serta disparitas akses antar wilayah masih menjadi isu utama dalam layanan kesehatan masyarakat Indonesia (Elungan et al., 2025).

Negara Indonesia mengalami transisi epidemiologi dimana beban penyakit menular tradisional bergeser ke double burden dengan meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, sementara penyakit menular seperti tuberkulosis tetap signifikan (Profil Kesehatan Indonesia, 2024). Transisi ini menuntut sistem kesehatan yang adaptif untuk menangani beban kronis jangka panjang sekaligus cepat merespons wabah atau penyakit baru seperti kasus wabah penyakit menular dan tantangan imunisasi rutin. Hal ini menunjukkan bahwa sistem surveillance dan cakupan imunisasi masih perlu diperkuat. Demikian halnya pencatatan tren penyakit pernapasan akut dan ancaman PTM di berbagai wilayah menjadi masalah yang bervariasi di setiap daerah. Pergeseran ini merupakan ciri khas transisi epidemiologi yang dialami oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Urbanisasi, perubahan gaya hidup, dan penuaan populasi menjadi faktor utama terjadinya double burden tersebut (Profil Kesehatan Indonesia, 2023).

Saat ini, tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia melibatkan aspek struktural dan konteks sosial ekonomi yang kompleks. Kemenkes RI menjelaskan bahwa sistem kesehatan nasional masih menghadapi kelemahan dalam kesiapan tenaga kesehatan, distribusi layanan, pembiayaan, serta keterpaduan data dan teknologi informasi. Hal ini diperkuat oleh analisis tantangan pembangunan kesehatan yang menyoroti transisi demografi, perubahan iklim, dan beban gizi

ganda sebagai faktor yang memperberat beban sistem kesehatan nasional Indonesia. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya soal layanan kuratif, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif dan promotif yang kuat serta kerja lintas sektor untuk menjawab determinan sosial dan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat (Kementerian Kesehatan RI., 2020).

Demikian halnya bahwa isu kesehatan masyarakat Indonesia erat kaitannya dengan kerangka global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan kebijakan nasional yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. SDG 3 menekankan “Good Health and Well-Being” atau menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan untuk semua usia, termasuk penurunan angka kematian ibu dan anak serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah juga mengintegrasikan target-target SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk penurunan stunting, peningkatan cakupan imunisasi, dan penguatan layanan kesehatan primer. Kebijakan nasional ini mencerminkan bahwa komitmen Indonesia untuk tidak hanya memenuhi target global, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan melalui transformasi enam pilar layanan, pembiayaan, SDM, dan teknologi agar tercipta pelayanan yang lebih responsif dan berkeadilan (Java et al., 2025).

B. Tujuan Penulisan buku

Buku ini disusun sebagai respon terhadap dinamika dan kompleksitas permasalahan kesehatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, demografi, dan epidemiologi. Berbagai tantangan seperti beban ganda penyakit, ketimpangan akses pelayanan kesehatan, serta tuntutan pencapaian pembangunan kesehatan yang berkelanjutan menuntut tersedianya sumber rujukan ilmiah yang komprehensif, mutakhir, dan aplikatif. Oleh karena itu, penulisan buku ini diarahkan untuk memberikan landasan konseptual dan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, institusi pendidikan kesehatan, hingga pemerintah, agar memiliki pemahaman yang selaras dan berbasis bukti dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk tujuan lebih rinci dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

1. Tujuan Penulisan Buku bagi Mahasiswa

- a. Memberikan pemahaman komprehensif tentang isu kesehatan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kondisi aktual dan perkembangan terkini.

- b. Membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis terhadap perubahan pola penyakit dan faktor determinan kesehatan masyarakat.
 - c. Menjadi sumber belajar yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada program pendidikan kesehatan.
 - d. Mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan berbasis bukti (evidence-based) dalam memahami permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia.
 - e. Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan terhadap peran promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan Penulisan Buku bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)
- a. Menjadi referensi ilmiah yang mutakhir dalam mendukung proses pembelajaran dan pengajaran di bidang kesehatan masyarakat.
 - b. Membantu dosen dalam menyusun materi ajar yang relevan dengan isu nasional dan global, termasuk SDGs dan kebijakan kesehatan.
 - c. Mendukung pengembangan metode pembelajaran berbasis kasus dan masalah kesehatan nyata di masyarakat.
 - d. Menjadi bahan rujukan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada isu kesehatan masyarakat.
 - e. Membantu tenaga kependidikan dalam memahami konteks kebijakan dan sistem kesehatan guna mendukung tata kelola pendidikan kesehatan yang berkualitas.
3. Tujuan Penulisan Buku bagi Institusi Pendidikan Kesehatan
- a. Mendukung pencapaian visi dan misi institusi pendidikan kesehatan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.
 - b. Menjadi bahan pendukung penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan kesehatan masyarakat dan kebijakan nasional.
 - c. Memperkuat mutu pembelajaran dan standar akademik sesuai dengan akreditasi program studi dan institusi.
 - d. Menjadi referensi institusional dalam penguatan tridarma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan penelitian.
 - e. Mendorong institusi pendidikan kesehatan berperan aktif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat di tingkat lokal dan nasional.
4. Tujuan Penulisan Buku bagi Pemerintah
- a. Menyediakan bahan rujukan akademik yang mendukung perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan masyarakat.
 - b. Membantu meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan terhadap isu prioritas kesehatan masyarakat di Indonesia.

- c. Mendukung upaya pencapaian target pembangunan kesehatan nasional dan Sustainable Development Goals (SDGs).
- d. Menjadi dasar penguatan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan tenaga kesehatan.
- e. Mendorong pengembangan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam perencanaan dan evaluasi program kesehatan.

C. Transisi Epidemiologi

Kejadian transisi epidemiologi penyakit di Indonesia menunjukkan pola yang bervariasi antar jenis penyakit, mencerminkan dinamika perubahan sosial, ekonomi, demografi, dan lingkungan yang terus berlangsung. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dominasi penyakit menular ke penyakit tidak menular, namun pada saat yang sama Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit akibat belum sepenuhnya teratasi masalah penyakit infeksi, gizi, dan kesehatan ibu serta anak. Variasi transisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan gaya hidup, tingkat pendidikan, ketimpangan akses pelayanan kesehatan, serta kondisi geografis dan budaya yang beragam di setiap wilayah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai transisi epidemiologi menjadi landasan penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan dan pengembangan strategi pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Berikut ini gambaran berbagai transisi epidemiologi penyakit di Indonesia (Departemen Kesehatan R.I, 2023).

1. Peralihan dari Penyakit Menular ke Penyakit Tidak Menular (PTM)

Transisi epidemiologi di Indonesia ditandai oleh perubahan dominasi penyebab penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM). Dalam tiga dekade terakhir, bukti menunjukkan bahwa beban penyakit menular perlahan menurun, sementara PTM seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker meningkat secara substansial di masyarakat Indonesia (Siswati, Muchlasin, et al., 2024). Hal ini mencerminkan tren global di mana negara-negara berkembang mulai menghadapi masalah kesehatan yang mirip dengan negara berpenghasilan tinggi terkait lifestyle dan faktor risiko kronis. Perubahan ini bukan sekadar statistik, namun menunjukkan perubahan pola kesehatan masyarakat Indonesia dari fase dominasi infeksi ke fase di mana penyakit kronis menjadi penyakit utama penyebab kematian dan morbiditas (Anggriyani et al., 2023).

Negara Indonesia saat ini menunjukkan bahwa, PTM kini menjadi penyebab utama kematian nasional. WHO dan data Global Burden of Disease menunjukkan bahwa sebagian besar penyebab kematian kini disumbang oleh PTM, terutama penyakit kardiovaskular, diikuti kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes.

Peralihan ini disebabkan interaksi faktor sosial dan lingkungan yang berkembang seperti urbanisasi, perubahan pola makan, dan gaya hidup yang semakin dominan. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu beradaptasi dengan pendekatan promotif dan preventif yang kuat, bukan hanya pelayanan kuratif terhadap infeksi saja (Hi et al., 2025).

Meskipun trend PTM meningkat, penyakit menular tetap menjadi masalah kesehatan penting di Indonesia. Demikian juga penyakit menular seperti tuberkulosis (TB), demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan HIV masih menunjukkan prevalensi dan dampak signifikan di beberapa wilayah, terutama di komunitas dengan akses pelayanan yang terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa transisi epidemiologi bukanlah penghapusan penyakit menular, melainkan penambahan beban baru yang membuat sistem kesehatan menghadapi double burden yang kompleks. Deteksi dini, intervensi kesehatan lingkungan, dan imunisasi masih penting untuk mengendalikan penyakit menular sambil upaya pencegahan PTM berjalan paralel.

Peralihan epidemiologi ini mencerminkan tantangan struktural dalam kebijakan kesehatan Indonesia: masih banyak kawasan di mana penyakit infeksi belum terkendali dengan baik sekaligus mencatat lonjakan PTM yang tajam. Kombinasi ini menuntut pendekatan multilevel dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Intervensi harus melibatkan kampanye perubahan perilaku, promosi kesehatan komunitas, serta penguatan layanan primer yang mencakup skrining PTM dan kontrol infeksi (Siswati, Iskandar, et al., 2024).

2. Beban Ganda Penyakit (Double Burden of Disease)

Indonesia menghadapi realitas berat, yakni beban ganda dari penyakit menular dan tidak menular secara bersamaan. Dalam konteks epidemiologi kesehatan, istilah ini menggambarkan situasi di mana penyakit infeksi seperti TB, DBD, serta penyakit tropis lain belum sepenuhnya teratasi, sementara PTM meningkat pesat (Rismarwati et al., 2024). Kondisi ini bukan hanya soal prevalensi, tetapi juga soal strategis Kesehatan seperti, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikan kedua jenis penyakit tersebut sangat berbeda dan menuntut berbagai intervensi yang simultan. Hal ini menunjukkan kompleksitas pembiayaan dan perencanaan program kesehatan nasional.

Beban ganda penyakit ini tercermin dari data nasional yang menunjukkan tetapnya kasus TB, malaria, dan DBD dalam populasi Indonesia, sekaligus meningkatnya angka kematian akibat stroke, penyakit jantung, dan kanker. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi dimana program kesehatan harus mencakup pengendalian infeksi sekaligus menangani risiko kronis jangka

panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa PTM kini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, namun masalah infeksi seperti TB masih menimbulkan morbiditas yang tinggi termasuk berjuta-juta kasus yang memerlukan perawatan intensif (Putri et al., 2025).

Double burden bukan hanya tantangan klinis, tetapi juga sistemik karena mempengaruhi strategi pencegahan dan pengendalian penyakit secara keseluruhan. Kebutuhan akan vaksinasi, skrining dini PTM, edukasi masyarakat, serta peningkatan akses layanan kesehatan primer harus disinergikan untuk menjawab dua beban sekaligus. Hal ini menciptakan kebutuhan kuat akan pendekatan multisektoral termasuk kolaborasi lintas sektor seperti pendidikan, lingkungan hidup, dan kebijakan pangan publik (Hidayat & Hasbyalloh, 2025).

Pendekatan pengendalian tersebut harus relevan terhadap tujuan pembangunan kesehatan nasional yang berkelanjutan. Tanpa penanganan simultan terhadap infeksi dan PTM, target penurunan angka kematian dini dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, strategi prioritas termasuk peningkatan kapasitas surveilans epidemiologis yang mampu memantau tren penyakit menular dan PTM secara real-time serta respon cepat terhadap wabah atau kenaikan risiko kronis.

3. Dampak Perubahan Gaya Hidup, Urbanisasi, dan Penuaan Penduduk

Perubahan gaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan penyakit tidak menular di Indonesia. Pola makan tidak sehat yang tinggi gula, garam, dan lemak, kombinasi dengan rendahnya aktivitas fisik, menjadi faktor risiko signifikan bagi timbulnya PTM seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Data survei kesehatan nasional menunjukkan prevalensi hipertensi dan diabetes terus meningkat, menandakan bahwa faktor perilaku kesehatan masyarakat perlu menjadi fokus utama pencegahan (Profil Kesehatan Indonesia, 2023). Gaya hidup minim gerak, konsumsi makanan olahan, serta paparan lingkungan berisiko seperti polusi juga memperburuk risiko PTM.

Urbanisasi merupakan faktor demografis lain yang mempengaruhi transisi epidemiologi. Migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota telah membawa perubahan pola hidup kurang aktifitas fisik dan mudahnya akses terhadap makanan tidak sehat. Lingkungan kota juga meningkatkan eksposur terhadap faktor risiko seperti stress, polusi udara, dan konsumsi makanan cepat saji yang berkaitan erat dengan kejadian obesitas dan PTM. Fenomena urbanisasi ini mempercepat pergeseran dari penyakit menular ke penyakit kronis yang lebih dominan di daerah perkotaan.

Penuaan penduduk juga memainkan peranan penting dalam perubahan epidemiologi di Indonesia. Dengan peningkatan angka harapan hidup, proporsi

penduduk usia lanjut meningkat, yang secara alami membawa peningkatan risiko penyakit kronis jangka panjang seperti penyakit kardiovaskular dan gangguan degeneratif lain. Penuaan populasi menuntut sistem kesehatan yang tidak hanya responsif terhadap penyakit akut, tetapi juga mampu menangani kondisi kronis jangka panjang dan rehabilitasi yang intensif (Hidayat & Hasbyalloh, 2025).

Faktor gaya hidup, urbanisasi, dan penuaan penduduk ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dalam membentuk transisi epidemiologi di Indonesia. Kombinasi ini mempercepat meningkatnya beban PTM sekaligus menuntut fokus kuat terhadap pengendalian faktor risiko melalui kebijakan kesehatan publik seperti promosi aktivitas fisik, regulasi pangan sehat, dan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menyediakan layanan manajemen penyakit kronis yang terintegrasi.

4. Peningkatan Kasus: Penyakit Infeksi (TB, HIV, DBD) dan PTM

Beberapa penyakit infeksi klasik seperti tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Menurut data WHO dan laporan nasional, Indonesia menempati peringkat tinggi kasus TB di dunia, dengan lebih dari satu juta kasus diperkirakan terjadi setiap tahunnya. Penyakit menular lain seperti HIV/AIDS dan demam berdarah dengue (DBD) juga tetap memerlukan perhatian strategis karena prevalensi dan dampaknya yang signifikan terhadap morbiditas. Meskipun secara umum angka TB menurun dalam jangka panjang, ketergantungan pada intervensi medis masih tinggi karena risiko resistensi obat dan rendahnya deteksi dini di beberapa wilayah (Sitepu et al., 2024).

Sementara penyakit menular masih ada, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan kanker menunjukkan tren peningkatan yang pesat. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi mencapai lebih dari 30% orang dewasa dan diabetes melitus sekitar 11–12%. Penyakit ini tidak hanya meningkat pada kelompok usia lanjut tetapi juga terlihat pada kelompok usia produktif, menunjukkan bahwa faktor perubahan gaya hidup dan risiko perilaku berkontribusi secara substansial terhadap epidemi PTM di Indonesia. Data ini memperkuat pergeseran beban penyakit dari infeksi ke kondisi kronis yang dominan di masyarakat (Yu et al., 2025).

Kombinasi kasus infeksi dan PTM yang berkembang ini menunjukkan tantangan luar biasa bagi sistem kesehatan Indonesia. Situasi ini memerlukan strategi kesehatan masyarakat yang komprehensif, mencakup promosi gaya hidup sehat, peningkatan layanan primer, serta kerja lintas sektor untuk mengatasi determinan sosial dari kedua kategori penyakit. Seluruh dinamika ini menggambarkan bahwa transisi epidemiologi Indonesia merupakan proses

berkelanjutan. Penanganan komprehensif untuk penyakit menular dan PTM menjadi kunci agar sistem kesehatan nasional dapat merespon tantangan beban ganda penyakit secara efektif dan berkelanjutan (Irfan Sazali Nasution et al., 2024).

D. Isu Penyakit Menular Prioritas di Indonesia

Penyakit menular masih menjadi isu kesehatan prioritas di Indonesia karena dampaknya yang signifikan terhadap angka kesakitan, kematian, serta beban sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian, berbagai penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih ditemukan dengan prevalensi yang relatif tinggi di berbagai wilayah. Kondisi ini berkaitan dengan faktor faktor kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, kesenjangan akses pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan yang belum optimal, dan tingkat literasi kesehatan yang beragam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai isu penyakit menular prioritas menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penguatan sistem kesehatan, dan peningkatan peran tenaga kesehatan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan. Berikut ini penjelasan singkat tentang kasus penyakit menular di Indonesia (Java et al., 2025).

1. Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis (TB), menjadi salah satu penyakit menular utama di Indonesia dengan jumlah kasus yang sangat tinggi dibandingkan negara lain. Laporan Kemenkes RI menunjukkan tren peningkatan kasus TB dari sekitar 443.235 kasus pada 2021 menjadi lebih dari 831.000 kasus pada 2024, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Faktor risiko utama TB mencakup kontak dekat dengan penderita aktif, kondisi gizi buruk, kepadatan hunian, dan faktor sosial ekonomi rendah yang memengaruhi daya tahan tubuh dan kemungkinan transmisi. Kondisi ini diperburuk oleh urbanisasi dan tingginya populasi yang rentan di perkotaan (Wahidin et al., 2023)

Tantangan dalam pengendalian TB di Indonesia meliputi rendahnya tingkat deteksi dini, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil, serta kurangnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan jangka panjang, terutama karena terapi TB memerlukan minimal 6 bulan pengobatan yang disiplin. Keterbatasan ini sering memicu kasus TB resisten obat (MDR-TB), yang memerlukan perawatan lebih kompleks dan biaya lebih tinggi. Selain itu, kolaborasi program TB–HIV diperlukan karena kedua penyakit ini saling memperburuk kondisi pasien (Yuliani & Ak, 2019).

Akibat kasus yang melonjak, terjadi dampak sosial TB mencakup stigma dan diskriminasi terhadap penderita, yang sering kali menghambat pencarian layanan kesehatan dan dukungan sosial. Secara ekonomi, keluarga penderita TB sering menghadapi penurunan produktivitas dan pendapatan karena sakit berkepanjangan serta biaya pengobatan tambahan meskipun layanan dasar disubsidi pemerintah. Stigma ini juga mendorong isolasi sosial yang lebih lanjut (Cahyati & Artikel, 2019).

Untuk mengatasi masalah penyakit TB, diperlukan solusi strategis yang diterapkan mencakup penguatan sistem deteksi dini melalui peningkatan kapasitas laboratorium, pendekatan pemeriksaan aktif di komunitas, serta penguatan program Directly Observed Treatment, Short-course (DOTS). Integrasi program TB dengan layanan primer, edukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian pengobatan, serta pembiayaan kesehatan yang memadai diharapkan dapat mempercepat penurunan kasus TB dan mengurangi beban sosial dan ekonomi (Yanful et al., 2023).

2. HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS)

HIV/AIDS dan IMS masih menjadi masalah kesehatan masyarakat signifikan di Indonesia, dengan puluhan ribu kasus baru dan populasi hidup dengan HIV yang tinggi. Data WHO menunjukkan bahwa cakupan pengobatan antiretroviral di Indonesia masih di bawah target global, meskipun sedikit meningkat dari sekitar 33% penduduk yang terdiagnosis pada 2022 menjadi sekitar 44% pada (Kamisna et al., 2023). Faktor risiko utama penularan HIV dan IMS termasuk hubungan seksual tanpa proteksi, penggunaan narkoba suntik, serta rendahnya akses dan pengetahuan tentang pencegahan IMS di kalangan remaja dan populasi kunci.

Pengendalian HIV/AIDS dan IMS menjadi tantangan yang berat karena ada hambatan pada layanan kesehatan seperti keterbatasan tes dan pengobatan, stigma terhadap ODHA (*Orang dengan HIV/AIDS*), serta kendala pendanaan dan koordinasi program. Selain itu, pendanaan dari mitra internasional terkadang fluktuatif, sehingga program pencegahan dan perawatan menjadi kurang stabil, terutama pada kelompok rentan. Upaya nasional melalui rencana aksi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan IMS (2020–2024) juga menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk deteksi dini dan pengurangan dampak sosial (Boy et al., 2019).

Dampak sosial ekonomi HIV/AIDS mencakup biaya perawatan jangka panjang, penurunan produktivitas kerja, serta stigma yang berkepanjangan terhadap ODHA dan keluarga mereka. Diskriminasi dalam pekerjaan atau layanan masyarakat memperburuk kondisi sosial, sementara secara ekonomi, biaya

pengobatan dan dukungan jiwa dapat menjadi beban berat bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Peningkatan edukasi kesehatan seksual dan promosi penggunaan kondom, perluasan akses *testing* dan *treatment* di fasilitas primer, serta penguatan program pencegahan ibu dan anak merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh setiap komponen yang terlibat. Selain itu, pelibatan komunitas serta dukungan kebijakan yang mengurangi stigma sangat penting untuk mendorong partisipasi dalam program HIV/AIDS dan IMS (Boy et al., 2019).

3. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*, masih menunjukkan prevalensi tinggi di banyak wilayah Indonesia karena iklim tropis dan sanitasi lingkungan yang kurang optimal. Data Kemenkes RI 2025 menunjukkan peningkatan suspek DBD yang terus dilaporkan secara mingguan, mengindikasikan DBD masih menjadi tantangan besar. Faktor risiko utama DBD mencakup keberadaan air tergenang di lingkungan rumah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam eliminasi sarang nyamuk, serta kurangnya pengetahuan tentang pencegahan virus dengue (Putri et al., 2025).

Kegiatan pengendalian DBD masih ditemukan kendala yaitu rendahnya keterlibatan masyarakat dalam program pengendalian vektor seperti PSN 3M Plus (Menguras, Menutup, Mengubur) serta kurangnya koordinasi lintas sektor untuk sanitasi lingkungan. Faktor klimatologis seperti curah hujan tinggi dan peningkatan suhu juga mendukung siklus hidup nyamuk yang lebih cepat. Di beberapa daerah endemis, upaya pengendalian vektor masih kurang efektif karena keterbatasan sumber daya lokal dan kapasitas surveilans.

Pengaruh DBD tidak dapat dihindari juga menimbulkan dampak sosial, mencakup gangguan aktivitas pendidikan dan kerja karena rawat inap atau sakit demam berkepanjangan, sementara dampak ekonomi termasuk biaya perawatan, kehilangan jam kerja, dan beban biaya keluarga. Dampak ini semakin terasa pada komunitas miskin yang memiliki akses layanan kesehatan terbatas dan rentan terhadap wabah musiman (Elungan et al., 2025).

Kebijakan dan tindakan pemecahan masalah yang strategis dapat diterapkan dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dan edukasi intensif tentang eliminasi sarang nyamuk, peningkatan program surveilans vektor, serta teknologi baru seperti penggunaan *Wolbachia* untuk mengurangi penularan DBD. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi penting untuk meningkatkan efektivitas upaya pengendalian.

4. Malaria (Daerah Endemis)

Malaria masih menjadi penyakit endemis di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di provinsi timur seperti Papua dan Papua Barat, dengan ratusan ribu kasus malaria dilaporkan pada 2023–2024. Faktor risiko utama malaria meliputi paparan tinggi terhadap nyamuk *Anopheles*, kondisi rumah tidak terlindungi, serta keterbatasan layanan kesehatan primer di daerah terpencil. Mobilitas penduduk lintas perbatasan dan lingkungan hutan-pedesaan juga memperbesar risiko penularan (Mapossa et al., 2021).

Penyakit malaria juga mengalami masalah dalam pengendalian termasuk kesulitan akses layanan diagnostik dan pengobatan di wilayah terpencil, resistensi obat antimalaria, serta keterbatasan laporan kasus yang dapat menghambat respon cepat pandemi lokal. Selain itu, fluktuasi pendanaan program nasional dan internasional kerap memengaruhi kontinuitas intervensi pengendalian vektor dan pemberian obat profilaksis serta terapi kombinasi efektif (Telaumbanua et al., 2025).

Oleh karena itu maka akan timbul dampak sosial dan ekonomi malaria yang tidak dapat dihindari, seperti penurunan produktivitas penduduk, mengalami demam berkepanjangan, biaya pengobatan yang signifikan bagi keluarga, serta beban kesehatan masyarakat yang meningkat di daerah endemis. Sektor pendidikan juga terdampak karena anak-anak sering absen sekolah akibat sakit malaria.

Untuk mengatasi masalah malaria, dengan peningkatan akses tes cepat dan pengobatan efektif, distribusi kelambu berinsektisida, serta program edukasi kesehatan masyarakat di wilayah endemis. Kerja sama publik, pihak swasta dan program penguatan surveilans serta eliminasi kasus pada daerah endemis menjadi strategi kunci dalam mengurangi beban malaria di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI., 2020).

5. Ancaman Penyakit Baru dan *Re-Emerging Diseases*

Selain penyakit menular klasik, Indonesia menghadapi ancaman penyakit baru dan re-emerging seperti mpox yang kembali dilaporkan muncul pada 2022–2024, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta. Faktor risiko munculnya penyakit ini termasuk globalisasi, mobilitas tinggi, perubahan iklim, dan interaksi manusia-hewan yang intens, yang dapat mempercepat penyebaran zoonotik dan penyakit baru.

Kesulitan melakukan pengendalian penyakit baru adalah keterbatasan kapasitas surveilans dan laboratorium untuk deteksi dini, serta kesiapsiagaan layanan kesehatan primer dalam merespon wabah yang tidak terduga. Re-emerging diseases juga menuntut adaptasi sistem kesehatan untuk

menggabungkan respon cepat, pengembangan protokol penanganan terbaru, serta komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat (Java et al., 2025).

Akibat adanya penyakit baru termasuk, masyarakat mengalami kebingungan informasi, stigma, serta gangguan ekonomi apabila terjadi wabah berskala besar yang memaksa pembatasan sosial atau penurunan aktivitas ekonomi. Dampak ekonomi dapat terlihat dari biaya respon kesehatan yang tinggi serta penurunan produktivitas akibat pembatasan aktivitas sosial.

Kebijakan penting dan strategis dapat dilakukan meliputi pembentukan early warning systems, peningkatan kapasitas surveilans nasional dan regional, penguatan koordinasi lintas sektor, serta investasi pada riset dan inovasi untuk deteksi cepat dan vaksin baru. Keterlibatan komunitas dan komunikasi risiko yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan pengendalian penyakit baru dan re-emerging (Komariah et al., 2025).

E. Masalah Penyakit Tidak Menular (PTM)

Masalah penyakit tidak menular (PTM) menjadi tantangan kesehatan utama di Indonesia seiring dengan perubahan gaya hidup dan sosial ekonomi lainnya. Penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker berkontribusi besar terhadap angka kesakitan, kematian, serta pembiayaan kesehatan, baik di tingkat individu maupun sistem pelayanan kesehatan. Peningkatan faktor risiko perilaku, seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi tembakau, dan stres, mempercepat beban PTM di berbagai kelompok usia, termasuk usia produktif. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai masalah PTM menjadi sangat penting sebagai dasar pengembangan kebijakan kesehatan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan peran tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pengendalian PTM secara berkelanjutan. Berapa penyakit PTM yang berkontribusi terhadap masalah Kesehatan di Indonesia (Hi et al., 2025).

1. Hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke, dan Penyakit Jantung

Hipertensi, diabetes melitus, stroke, dan penyakit jantung merupakan kelompok penyakit tidak menular (PTM) dengan kontribusi terbesar terhadap angka kematian dan disabilitas di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 tahun mencapai lebih dari 30%, sementara prevalensi diabetes melitus terus meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Penyakit kardiovaskular, termasuk stroke dan penyakit jantung koroner, menjadi penyebab kematian tertinggi dan menyumbang beban ekonomi kesehatan yang sangat besar (Muslimin, 2025).

Peningkatan kejadian PTM ini sangat erat kaitannya dengan pola hidup tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, rendah serat, serta kurangnya aktivitas fisik. Perilaku sedentari akibat perubahan gaya hidup modern, penggunaan transportasi bermotor, dan pekerjaan yang minim aktivitas fisik berkontribusi terhadap obesitas dan gangguan metabolik. Selain itu, prevalensi merokok yang masih tinggi di Indonesia mempercepat risiko hipertensi, penyakit jantung, dan stroke melalui mekanisme kerusakan pembuluh darah dan stres oksidatif (Salsabila, 2024).

PTM menimbulkan dampak kardiometabolik tidak hanya bersifat medis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Penyakit ini sering menyerang usia produktif sehingga menurunkan produktivitas kerja, meningkatkan ketergantungan keluarga, serta menambah beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Stroke, misalnya, sering menyebabkan kecacatan jangka panjang yang memerlukan rehabilitasi berkelanjutan dan dukungan keluarga, sehingga berdampak pada kualitas hidup penderita dan keluarganya (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (Yu et al., 2025).

Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif dengan penguatan layanan kesehatan primer, termasuk skrining tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara rutin. Program *Gerakan Masyarakat Hidup Sehat* (GERMAS) serta pengendalian konsumsi rokok dan makanan tidak sehat menjadi strategi kunci. Selain itu, penciptaan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik dan akses terhadap pangan sehat diperlukan agar perubahan perilaku dapat berkelanjutan (Hartini et al., 2025).

2. Kanker

Kanker merupakan salah satu PTM yang terus menunjukkan peningkatan insidensi dan mortalitas di Indonesia. Data nasional menunjukkan bahwa kanker termasuk dalam lima besar penyebab kematian akibat PTM, dengan jenis kanker yang paling sering ditemukan antara lain kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, dan kanker kolorektal. Tantangan utama pengendalian kanker di Indonesia adalah tingginya proporsi diagnosis pada stadium lanjut, yang menurunkan peluang kesembuhan dan meningkatkan biaya pengobatan (Solekhudin et al., 2022).

Faktor risiko kanker sangat berkaitan dengan pola hidup tidak sehat, khususnya perilaku merokok dan konsumsi alkohol. Merokok merupakan faktor risiko utama kanker paru, mulut, dan laring, sementara alkohol berkontribusi terhadap kanker hati dan saluran cerna. Selain itu, pola makan tidak seimbang yang rendah serat dan tinggi lemak serta obesitas meningkatkan risiko kanker

payudara, usus besar, dan pankreas. Kurangnya aktivitas fisik juga berperan dalam mekanisme inflamasi kronis yang memicu perkembangan kanker (Yuliani, 2019).

Pengaruh sosial dan ekonomi oleh penyakit kanker sangat besar karena pengobatan memerlukan waktu lama, teknologi tinggi, dan biaya tinggi. Pasien kanker sering mengalami penurunan kualitas hidup, kehilangan pekerjaan, serta tekanan psikologis yang berat. Bagi keluarga, kanker dapat menyebabkan beban finansial signifikan meskipun terdapat perlindungan JKN, terutama untuk biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapatan (Irfan Sazali Nasution et al., 2024).

Oleh karena itu, pengendalian kanker menekankan pada pencegahan primer dan deteksi dini melalui perubahan gaya hidup sehat, pengendalian rokok dan alkohol, serta peningkatan aktivitas fisik. Program skrining kanker serviks dan payudara di layanan primer perlu diperluas dan diperkuat, disertai edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Kebijakan lintas sektor, termasuk regulasi tembakau dan promosi gizi seimbang, sangat penting dalam menurunkan beban kanker secara berkelanjutan (Cahyati, 2019).

3. Gangguan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental merupakan bagian penting dari penyakit tidak menular yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan terkait stres. Data nasional menunjukkan peningkatan prevalensi gangguan mental emosional, terutama pada kelompok usia produktif dan remaja, seiring dengan tekanan sosial, ekonomi, dan perubahan gaya hidup modern. Masalah kesehatan mental sering tidak terdeteksi karena rendahnya literasi kesehatan mental dan masih kuatnya stigma di masyarakat (Komariah et al., 2025).

Faktor lain yang ikut berkontribusi terhadap Kesehatan mental yaitu pola hidup tidak sehat kurangnya aktivitas fisik, pola tidur yang buruk, serta konsumsi rokok dan alkohol dapat memperburuk kondisi psikologis melalui gangguan regulasi hormon dan neurotransmitter. Alkohol dan nikotin sering digunakan sebagai mekanisme koping yang tidak sehat, namun justru meningkatkan risiko depresi dan kecemasan jangka panjang (Rosin et al., 2023).

Gangguan kesehatan mental menimbulkan dampak sangat luas, mencakup penurunan produktivitas kerja, meningkatnya angka absensi, serta gangguan fungsi sosial dan keluarga. Dalam jangka panjang, gangguan mental yang tidak tertangani dapat meningkatkan risiko bunuh diri dan memperburuk penyakit fisik lain seperti penyakit jantung dan diabetes. Beban ekonomi akibat gangguan mental juga signifikan karena meningkatnya biaya layanan kesehatan dan kehilangan produktivitas nasional (Irene et al., 2025).

Pemerintah melakukan berbagai strategi penanganan gangguan kesehatan mental menekankan integrasi layanan kesehatan mental ke dalam pelayanan kesehatan primer, penguatan deteksi dini, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Promosi gaya hidup sehat, aktivitas fisik teratur, dan pengurangan konsumsi rokok serta alkohol juga berperan sebagai upaya pencegahan. Selain itu, edukasi publik dan pengurangan stigma menjadi kunci agar masyarakat lebih terbuka dalam mengakses layanan kesehatan mental (Hazazi & Wilson, 2022).

F. Masalah Kesehatan Ibu, Anak, Dan Remaja

Masalah kesehatan ibu, anak, dan remaja masih menjadi isu strategis kesehatan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan. Data menunjukkan bahwa di Indonesia, angka kematian ibu masih relatif tinggi sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup, disertai tantangan lain seperti angka kelahiran remaja 26,6 per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun dan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi sekitar 18%. Selain itu, kelompok remaja menghadapi berbagai risiko kesehatan seperti peningkatan perilaku merokok, masalah kesehatan mental, penyakit menular, serta gaya hidup tidak sehat yang meningkatkan risiko anemia, obesitas, dan stunting. Pada sisi anak, masih terdapat masalah kematian bayi baru lahir, stunting, serta kesenjangan akses pelayanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pelayanan kesehatan reproduksi, gizi, kesehatan mental, dan akses layanan kesehatan yang merata menjadi kunci dalam menurunkan risiko kesakitan dan kematian pada kelompok ibu, anak, dan remaja. Berikut ini beberapa isu Kesehatan ibu dan anak (Simamora, 2021).

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi jika dibandingkan target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Menurut laporan WHO dan Kementerian Kesehatan RI, AKI di Indonesia sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB pada 2023 dilaporkan mencapai hampir 30.000 kematian bayi dalam setahun, dengan angka kematian neonatal cukup besar dari keseluruhan kematian bayi. AKI tinggi ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan ibu belum optimal meskipun terdapat peningkatan akses layanan kesehatan (Profil Kesehatan Indonesia, 2023).

Beberapa faktor risiko utama yang mempengaruhi AKI antara lain perdarahan, preeklamsia/hipertensi kehamilan, serta kegagalan deteksi dini komplikasi kehamilan, ditambah prevalensi anemia dan penyakit penyerta lain seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular pada ibu hamil (Sampling

Registration System menunjukkan sebagian besar kematian ibu terjadi saat persalinan dan pascapersalinan. Ketimpangan akses layanan kesehatan dan keterlambatan kunjungan antenatal care (ANC) juga menjadi faktor penting yang memperburuk outcomes bayi dan ibu (Salsabila et al., 2022).

Adapun dampak sosial dan ekonomi dari tingginya AKI dan AKB sangat tinggi. Keluarga yang kehilangan ibu atau bayi mengalami trauma psikologis, beban ekonomi akibat biaya perawatan, serta hilangnya kontribusi produktif keluarga. Di level komunitas, tingginya angka kematian ini menghambat kemajuan sosial dan kesehatan umum masyarakat karena menandakan rendahnya kualitas sistem kesehatan maternal-anak.

Kebijakan dan strategi intervensi yang dibutuhkan meliputi penguatan layanan ANC berkualitas tinggi dan deteksi dini risiko kehamilan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di fasilitas primer, serta edukasi komunitas tentang tanda bahaya kehamilan. Penekanan pada kolaborasi lintas sektor, termasuk pemberdayaan perempuan untuk akses keputusan Kesehatan juga penting dalam menekan AKI dan AKB.

2. Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi merujuk pada kondisi di mana ibu hamil mengalami faktor medis atau sosial yang dapat meningkatkan kemungkinan komplikasi baik pada ibu maupun bayi. Risiko ini meliputi usia ibu terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun), riwayat penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, serta status gizi buruk. Pola pernikahan dini di Indonesia masih cukup tinggi, dengan angka perkawinan anak mencapai puluhan per seribu, yang secara langsung meningkatkan risiko komplikasi kehamilan karena organ reproduksi fisik remaja belum matang (Putri et al., 2025).

Usia kehamilan yang terlalu muda juga berhubungan dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan prematuritas. Studi di beberapa daerah menunjukkan bahwa perempuan yang menikah dan hamil di usia muda memiliki risiko kelahiran prematur yang lebih tinggi dibandingkan usia optimal. Kondisi ini memengaruhi kemungkinan bayi mengalami gangguan kesehatan sejak lahir, termasuk risiko mortalitas neonatal lebih tinggi (Guta, 2022).

Kehamilan risiko tinggi berdampak sangat luas, mulai dari tingginya biaya kesehatan untuk perawatan komplikasi hingga dampak psikososial bagi ibu muda atau keluarga. Ibu hamil risiko tinggi lebih rentan mengalami perdarahan, preeklamsia yang mengancam jiwa, serta masalah kesehatan ibu pascapersalinan. Bagi bayi, kelahiran prematur atau BBLR berkaitan dengan morbiditas jangka panjang seperti gangguan tumbuh kembang dan kebutuhan perawatan intensif neonatal.

Solusi intervensi mencakup pencegahan pernikahan dini, terutama melalui edukasi kesehatan reproduksi kepada remaja dan keluarga, serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan ANC yang menekankan skrining risiko sejak awal kehamilan. Upaya ini harus didukung kebijakan yang menguatkan hak reproduksi perempuan dan akses yang setara ke layanan kesehatan yang bermutu.

3. Kesehatan Neonatal

Kesehatan neonatal mencakup kondisi bayi baru lahir mulai dari lahir hingga usia 28 hari. Meski Indonesia berhasil menurunkan angka kematian neonatal dalam beberapa dekade terakhir, angka tersebut masih di atas target SDGs, yakni sekitar <15 per 1.000 kelahiran hidup, dengan puluhan ribu kematian setiap tahunnya, kebanyakan terjadi pada minggu pertama kehidupan (Profil Kesehatan Indonesia, 2023).

Faktor risiko neonatal mortality meliputi prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), asfiksia lahir, dan sepsis neonatorum. Prematuritas dan BBLR terutama berkaitan dengan kondisi ibu selama kehamilan serta kualitas layanan obstetrik dan perawatan neonatal, seperti manajemen persalinan dan ketersediaan perawatan intensif neonatal.

Tingginya angka kematian dan morbiditas neonatal berdampak tidak hanya berimplikasi pada kematian bayi, tetapi juga pada kesenjangan kesehatan jangka panjang. Bayi yang lahir prematur atau BBLR yang berhasil bertahan hidup memiliki risiko gangguan tumbuh kembang, masalah pernapasan, dan kemungkinan keterlambatan perkembangan jangka panjang, yang dapat meningkatkan beban layanan kesehatan pediatrik di masa depan.

Untuk mengatasi beberapa masalah diatas ada beberapa solusi kesehatan neonatal melibatkan penguatan layanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta layanan perawatan intensif neonatal di fasilitas kesehatan. Intervensi tersebut perlu dilengkapi dengan akses luas ke imunisasi, deteksi dini masalah neonatal, serta pendidikan bagi ibu tentang perawatan bayi baru lahir, termasuk ASI eksklusif dan pengaturan suhu tubuh bayi (Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, 2025).

4. Masalah Kesehatan Remaja (Anemia, Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi)

Anemia pada remaja, terutama remaja putri, merupakan masalah kesehatan yang signifikan di Indonesia. Data menunjukkan prevalensi anemia remaja masih tinggi, yakni sekitar 15–29,7% pada kelompok usia 15–24 tahun meskipun ada tren penurunan, tetapi angka ini masih di atas ambang batas WHO yang dianggap mengkhawatirkan (> 10%). Anemia pada remaja putri sering disebabkan oleh kebutuhan zat besi yang tinggi selama pertumbuhan dan menstruasi,

dikombinasikan dengan pola makan tidak seimbang rendah zat besi (Kemenkes RI, 2023).

Pernikahan dini juga menjadi masalah kesehatan reproduksi yang memengaruhi remaja, karena pernikahan dan kehamilan di usia muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan kelahiran prematur. Menurut BKKBN, pernikahan pada usia di bawah 18 tahun tetap rentan dan berkaitan langsung dengan tingginya AKI dan AKB serta masalah kesehatan bayi seperti stunting dan BBLR.

Kesehatan remaja yang bermasalah seperti anemia atau kehamilan usia dini mempunyai dampak, diantaranya gangguan konsentrasi belajar, penurunan prestasi akademik, serta gangguan perkembangan fisik dan kognitif. Selain itu, remaja yang memasuki fase reproduktif terlalu dini berisiko menghadapi komplikasi kebidanan di kemudian hari, sekaligus menambah beban sistem kesehatan nasional (Pabidang et al., 2025).

Strategi dan tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan remaja mencakup edukasi gizi dan kesehatan reproduksi di sekolah, kampanye pencegahan anemia dengan suplementasi zat besi, program penundaan usia pernikahan, dan peningkatan akses layanan kontrasepsi yang aman bagi remaja. Upaya lintas sektor dengan pelibatan keluarga dan komunitas penting untuk mengubah norma sosial yang mempengaruhi kesehatan remaja (Nasution et al., 2025).

G. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Hambatan penanganan masalah kesehatan di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh faktor sistemik dan struktural. Salah satu kendala utama adalah ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama akibat distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil. Selain itu, masih terdapat kesenjangan cakupan layanan kesehatan tertentu, seperti pelayanan HIV dan penyakit tidak menular (PTM) yang deteksi serta pengobatannya masih rendah. Beban biaya kesehatan juga masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat, di mana sekitar 26,6% penduduk masih mengalami kesulitan finansial akibat pengeluaran kesehatan. Tantangan lain termasuk ketersediaan obat yang belum stabil akibat masalah pengadaan, rantai pasok, dan ketergantungan bahan baku impor, serta keterbatasan sistem data dan surveilans kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah dan masyarakat terus mengembangkan berbagai strategi. Pemerintah memperkuat transformasi sistem kesehatan melalui penguatan pelayanan primer, peningkatan kualitas data

kesehatan, reformasi pengadaan obat, serta penguatan kemitraan lintas sektor. Program jaminan kesehatan nasional juga terus diperluas untuk meningkatkan perlindungan finansial masyarakat. Di sisi lain, peran masyarakat sangat penting melalui peningkatan kesadaran kesehatan, partisipasi dalam program skrining dan pencegahan penyakit, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan nasional secara berkelanjutan.

H. Simpulan

Isu masalah kesehatan di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam perluasan akses layanan kesehatan dan penurunan beberapa indikator kesehatan, tantangan besar masih tetap ada. Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular seperti ISPA dan TB yang masih mendominasi jumlah kasus, serta peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker yang semakin membebani sistem kesehatan. Selain itu, masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian karena angka kematian ibu dan bayi masih relatif tinggi dibanding target global, serta masih terdapat kesenjangan akses layanan kesehatan antar wilayah. Upaya transformasi sistem kesehatan, penguatan layanan promotif dan preventif, serta peningkatan pemerataan akses layanan menjadi kunci untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan di masa depan.

I. Referensi

- Anggriyani, R., Studi, P., Biologi, P., Matematika, F., Alam, P., & Negeri, U. (2023). *Analisis Penyakit Malaria Akibat Infeksi Plasmodium sp terhadap Darah Manusia Analysis of Malaria Disease Caused by Plasmodium sp Against Human Blood disebabkan oleh spesies Plasmodium sp , ini hampir semua komponen darah , Penurunan berbagai sumber antara lain buku , jurnal , artikel terdapat 20 artikel yang terinklusi dan dapat. 08(1), 30–37.*
- Boy, P., Siahaan, C., & Lubis, R. (2019). *Jurnal Kesmas Prima Indonesia Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya TB paru pada pasien HIV / AIDS. 3(2), 17–23. <https://doi.org/10.34012/jkpi.v3i2.558>*
- Cahyati, W. H., & Artikel, I. (2019). *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 3(2), 168–178.*
- Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. (2025). *Kepdirjen Kesehatan Primer Dan Komunitas Nomor Hk.02.02-B-576-2025 Tentang Juknis Pmt Lokal Bagi Ibu Hamil Dan Balita Bermasalah Gizi.*

- Elungan, A. N. F., Baharuddin, M., Tjenreng, Z., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2025). *Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan*. 8(1), 170–177.
- Guta, N. M. (2022). Application of Donabedian quality - of - care framework to assess quality of neonatal resuscitation , its outcome , and associated factors among resuscitated newborns at public hospitals of East Wollega zone , Oromia , Western. *BMC Pediatrics*, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12887-022-03638-y>
- Hartini, S., Mangarengi, Y., Nurachma, E., & Asih, O. R. (2025). *Edukasi Aktivitas Fisik sebagai Upaya Program Gerakan Masyarakat Sehat Menuju Indonesia Sehat 2025*. 03(03), 349–353.
- Hazazi, A., & Wilson, A. (2022). Noncommunicable diseases and health system responses in Saudi Arabia: focus on policies and strategies. A qualitative study. *Health Research Policy and Systems*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00872-9>
- Hi, F., Kunoli, Y., & Kunci, K. (2025). *Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular di Desa Lalos Kabupaten Toli-Toli Early Detection of Risk Factors for Non-Communicable Diseases in Lalos Village , Toli-Toli Regency Artikel Pengabdian Article History: pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular . Menurut WHO penyakit Tidak Menular 2023 adalah Provinsi Kalimantan Tengah , Provinsi Kalimantan Selatan , dan Provinsi Jawa Barat . penyakit yang sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan , perilaku , transisi demografi teknologi , ekonomi nasional terancam akibat peningkatan prevalensi penyakit tidak menular . Posbindu PTM berkesinambungan . Melalui Posbindu PTM program pencegahan faktor risiko PTM di masyarakat Publisher: Universitas Muhammadiyah Palu. 8(6), 2837–2846. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7832>*
- Hidayat, U., & Hasbyalloh, M. S. (2025). *Strategi Peningkatan Cakupan Skrining Penyakit Tidak (Hipertensi Dan Diabetes Melitus) Di UPTD Puskesmas Cisalak Menular Strategies to Increase Non-Communicable Disease Screening Coverage (Hypertension and Diabetes Mellitus) at UPTD Puskesmas Cisalak*. 6(1), 47–52.
- Indonesia, P. K. (2023). *PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2023*.
- Indonesia, P. K. (2024). *Profil Kesehatan*.
- Irene, M., Beluan, S., Budiati, T., Rahmah, H., & Rachmawati, I. N. (2025). *A systematic review*. 19(2), 267–276.
- Irfan Sazali Nasution, Nurhazizah Br Said, Mutiara Salsabila, Ayu Maulidia, Zahwa Sinta Aulia, & Suci ramadhani. (2024). Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi. *Vitamin : Jurnal Ilmu Kesehatan*

Umum, 2(3), 195–206. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i3.509>

Java, W., Rochimat, I., Martihandini, N., Kesehatan, P., & Kesehatan, K. (2025). *Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Akibat Re-emerging atau Emerging infectious Diseases (Re-IEDs) di Kota Tasikmalaya Jawa Barat Pendahuluan Emerging infectious diseases (IEDs) adalah penyakit penyakit menular yang muncul secara tiba-tiba , contohnya seperti bencana covid-19 , sedangkan Re- emerging adalah penyakit penyakit yang sebelumnya telah ada tetapi kemudian menghilang dan tiba-tiba muncul kembali dalam bentuk klinis baru , yang bisa jadi lebih parah atau fatal dari sebelumnya , contohnya adalah avian influenza , polio dan lainnya (Rochimat et al . , 2023). Re- emerging dan emerging infectious diseases akan selalu ada dan terus menerus mengancam kesehatan masyarakat (Zumla and Hui , 2019). Covid-19 memperlihatkan bagaimana sebuah penyakit menjadi bencana bagi seluruh kehidupan manusia dan kita melihat bagaimana fasilitas kesehatan dan pemerintah tidak mampu mengatasi secara cepat efek yang ditimbulkan dari Covid-19 tersebut . Menghabiskan biaya ratusan triliun untuk vaksin dan fasilitas kesehatan (Kim and Loayza , 2022). Covid-19 sampai saat ini masih belum selesai atau masih meninggalkan dampak pada berbagai bidang , padahal masih banyak penyakit EIDs lainnya yang dapat menimbulkan bencana kesehatan . Untuk itu kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya bencana kesehatan (non alam) menjadi sangat penting dalam menghadapi terjadinya bencana kesehatan di masa depan . Maka dari itu , mencegah dan mengatasi penyakit Re- / IEDs tidak cukup hanya pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditingkatkan tetapi juga perlu peran semua pihak terutama peran masyarakat untuk ikut dalam mengontrol dan meningkatkan kesehatannya melalui kesiapsiagaan dalam menghadapi Re- / IEDs yang akan terus selalu ada . Berbagai penelitian menunjukkan bahwa suatu program kesehatan masyarakat akan sukses apabila berbasis kebutuhan komunitas masyarakat . Konsep program berbasis komunitas telah berkembang sejak 30 tahun terakhir dan terus dikembangkan dalam mengatasi masalah kesehatan maupun meningkatkan kesehatan di masyarakat (Rochimat , Prabandari and Dewi , 2021). Menurut Laverack dalam Rochimat (2021) , pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu meningkatkan sumber daya dan karakter / keunikan mereka untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas kehidupan mereka dan memiliki maksud yang jelas untuk membawa perubahan sosial dan politik , biasanya dengan memengaruhi kebijakan publik , otoritas pengambilan keput... 8(1), 24–36. <https://doi.org/10.32524/jksp.v8i1.1384>*

Kamisna, S., Purba, R., Yuni, R., Ginting, M., Paru, T., & Klinis, I. (2023). 1*, 2 1 2. 15.

- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. *Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI 351.077*, 1–99. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/ef5bb48f4aaae60ebb724caf1c534a24.pdf>
- Kesehatan, D., Gizi, D. A. N., Manusia, K. P., Kebudayaan, M. D. A. N., Perencanaan, B., & Nasional, P. (n.d.). *transisi demografi dan epidemiologi : di indonesia transisi demografi dan epidemiologi : di indonesia*.
- Komariah, N., Lestari, D., & Amanda, A. (2025). *Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kelurahan Tugu Kecil RT 003 RW 004 Kota Prabumulih Tahun 2024*. 2(11), 5043–5047.
- Mapossa, A. B., Focke, W. W., Tewo, R. K., Androsch, R., & Kruger, T. (2021). Mosquito-repellent controlled-release formulations for fighting infectious diseases. *Malaria Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12936-021-03681-7>
- Muslimin, I. (2025). Pengaruh Konsumsi Kopi Terhadap Peningkatan Tekanan Darah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Gizi*, 3(2), 182–193. <https://doi.org/10.55606/jig.v3i2.4375>
- Nasution, I. S., Maghirah, A. Al, Azkia, A. N., Nazwa, A., Sastra, D., & Sitorus, B. (2025). *GERMAS SEBAGAI STRATEGI NASIONAL : EVALUASI KEBIJAKAN*. 6, 9166–9177.
- Pabidang, S., Ernawati, E., Studi, P., Kebidanan, M., Guna, S., Yogyakarta, B., Artikel, I., Putri, R., Pabidang, S., Studi, P., & Kebidanan, M. (2025). *Edukasi kesehatan tentang pencegahan anemia pada remaja putri di smp bintang langkat 1,2,3*. 4(2), 96–105.
- Penyakit, I., Upipi, I., & Soetomo, R. (2023). *No Title*. 15.
- Putri, A. L., Saputra, K., Rozalia, K., Tamara, R., Silvia, R., Rosida, S., Triani, S. S., & Wulandari, S. (2025). *Penyuluhan Kesehatan sebagai upaya Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Palembang*. 7(1), 23–30.
- Putri, R., Wayuni, S., & Kala, P. R. (2025). *Deteksi Dini Kesehatan Mental Emosional Siswa Sekolah Menengah Atas Sebagai Langkah Awal Menciptakan Generasi Unggul*. 4.
- RI Kemenkes. (2018). Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (p. 198). http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Rismarwati, I., Diniah, F., & Sayekti, J. (2024). *OVERVIEW OF MOLECULAR RAPID TEST RESULTS AND RISK FACTORS FOR PULMONARY TUBERCULOSIS IN PATIENTS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS Diagnosis TB paru ditegakkan berdasarkan metode Real Time Polymerase Chain Reaction*

Assay (RT-PCR) semi kuantitatif, rekomendasi penggunaan metode TCM secara tajam seiring dengan memburuknya pada pasien HIV berkaitan langsung. 9(2), 268–278.

- Rosin, M., Mackay, S., Gerritsen, S., Morenga, L. Te, & Terry, G. (2023). *Barriers and facilitators to implementation of healthy food and drink policies in public sector workplaces : a systematic literature review* (Vol. 82, Issue 4).
- Salsabila, A. (2024). *GANGGUAN KESEHATAN MENTAL DAN KUALITAS. 2*, 25–33.
- Salsabila, S., Noviyanti, R. D., Pertiwi, D., Kusudaryati, D., Kunci, K., & Pendidikan, T. (2022). *Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dan Pola Asuh Orang Tua dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 12-36 Bulan di Wilayah Puskesmas Sangkrah. 19(2)*, 143–151.
- Simamora, T. M. (2021). *Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil di Masa Pandemi. 1*.
- Siswati, T., Iskandar, S., Pramestuti, N., & Raharjo, J. (2024). *Can the Target of 40 % Stunting Reduction by 2024 Be Reached ? 51(10)*, 2375–2376.
- Siswati, T., Muchlasin, A., Kristyanto, R. Y., Citra, D., & Gunawan, D. (2024). *Health Dynamics Determinants and Model for Estimating the Prevalence of Stunting Toddlers in Sleman Regency Health Dynamics. 1(6)*, 191–198.
- Sitepu, S., Sihombing, H., Nadapdap, F. M., Ann, S. C., & Purba, B. (2024). *PREVALENSI PENYAKIT HIV / AIDS DENGAN TUBERKULOSIS DI RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA MEDAN JANUARI – DESEMBER 2023. 8(11)*.
- Solekhudin, A. I., Ma'rifah, A. R., & Utami, T. (2022). *Asuhan Keperawatan Gangguan Mobilitas Fisik pada Pasien Post Sectio Caesarea. Journal of Management Nursing, 2(1)*, 177–183. <https://doi.org/10.53801/jmn.v2i1.79>
- Telaumbanua, N., Jernih, L., Daeli, H., Agustin, D., Islam, U., Sumatera, N., Khairunisa, S. S., Aulia, J., & Syifaurridha, N. (2025). *Masalah Kebijakan Kesehatan. 5*, 45–55.
- Yanful, B., Kirubarajan, A., Bhatia, D., Mishra, S., Allin, S., & Ruggiero, E. Di. (2023). *Quality of care in the context of universal health coverage : a scoping review. Health Research Policy and Systems, 1–29.* <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00957-5>
- Yu, X., Nursing, M., Xia, X., & Medicine, D. (2025). *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases Effect of holistic nursing intervention based on harmonious nursing theory on patients in stroke recovery period. 34(October)*.
- Yuliani, I., & Ak, D. (2019). *Pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit New-Emerging Dan Re-Emerging , Studi Kasus Pada Penyakit MERS-CoV Dan Ebola Di Kantor Kesehatan Pelabuhan. 4(1)*.

CHAPTER 2

KESEHATAN IBU DAN ANAK SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN

Bdn. Septiwiarsi, SST., M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Ibu dan anak termasuk kelompok rentan yang sangat memerlukan perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih menjadi tantangan besar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, upaya peningkatan Kesehatan ibu dan anak mendapat perhatian khusus (umami fitroul siti, 2022)

Kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan komponen fundamental dalam pembangunan kesehatan nasional karena berperan langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Status kesehatan ibu sejak masa remaja, kehamilan, persalinan, hingga nifas sangat menentukan kelangsungan hidup serta kualitas tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2020a).

Angka kematian ibu terus menjadi tantangan signifikan bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. Di Indonesia, penanganan angka kematian ibu masih menjadi agenda yang belum selesai dan diakui sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional. Isu ini membutuhkan perhatian yang lebih tinggi dan komitmen berkelanjutan terhadap program kesehatan ibu yang efektif untuk memastikan perawatan berkelanjutan. Pada tahun 2020, Indonesia melaporkan total 4.627 kematian ibu, yang mencerminkan peningkatan 10,25% dari total tahun sebelumnya yaitu 4.197. (Asnawi et al., 2025)

Secara global, masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan utama, khususnya di negara berkembang. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa sekitar 95% kematian ibu terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas (WHO, 2022). Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) mencerminkan belum optimalnya

akses terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya kualitas layanan, serta masih kuatnya pengaruh determinan sosial seperti pendidikan, kemiskinan, dan lingkungan (World Health Organization & UNICEF, 2021)

Di Indonesia, kesehatan ibu dan anak telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta berbagai kebijakan strategis Kementerian Kesehatan yang berfokus pada percepatan penurunan AKI, AKB, dan prevalensi stunting (Bappenas, 2020) Pemerintah menempatkan program kesehatan ibu dan anak sebagai intervensi strategis karena dampaknya yang luas terhadap peningkatan kualitas generasi masa depan dan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pendekatan pembangunan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan melalui konsep *continuum of care*, yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, hingga anak usia dini (World Bank, 2016) Pendekatan ini menekankan pentingnya pelayanan promotif dan preventif, deteksi dini faktor risiko, serta sistem rujukan maternal dan neonatal yang efektif.

Selain pelayanan kesehatan, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak juga memerlukan keterlibatan lintas sektor serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Pendidikan kesehatan, penguatan peran kader, pemanfaatan buku KIA, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer menjadi strategi penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak (Kemenkes RI, 2020a)

Sejalan dengan agenda global *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk, kesehatan ibu dan anak menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan berkelanjutan (United Nation, 2015) Dengan demikian, penguatan program kesehatan ibu dan anak bukan hanya merupakan kewajiban sektor kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

B. Konsep Dasar Kesehatan Ibu dan Anak

1. Pengertian Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan sejak masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga anak usia lima tahun (Kemenkes RI, 2020a)

2. Ruang Lingkup Kesehatan Ibu dan Anak

Menurut (Purnamasari, D., 2021) Ruang lingkup KIA meliputi seluruh tahapan siklus kehidupan manusia (*life cycle approach*), yaitu:

a. Kesehatan Remaja

- 1) Kesehatan reproduksi remaja
- 2) Pencegahan anemia remaja putri
- 3) Edukasi gizi dan kesehatan seksual

b. Kesehatan Ibu Hamil

- 1) Pelayanan antenatal care (ANC) terpadu
- 2) Deteksi dini kehamilan risiko tinggi
- 3) Pencegahan anemia dan KEK
- 4) Imunisasi ibu hamil

c. Kesehatan Ibu Bersalin

- 1) Persalinan aman oleh tenaga kesehatan
- 2) Pencegahan perdarahan dan infeksi
- 3) Pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED)

d. Kesehatan Ibu Nifas

- 1) Pemantauan involusi uterus
- 2) Pencegahan komplikasi nifas
- 3) Dukungan menyusui dan KB pasca persalinan

e. Kesehatan Bayi Baru Lahir

- 1) Pelayanan neonatal esensial
- 2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- 3) Pencegahan hipotermia dan infeksi

f. Kesehatan Bayi dan Balita

- 1) ASI eksklusif
- 2) MP-ASI sesuai usia
- 3) Imunisasi dasar lengkap
- 4) Pemantauan tumbuh kembang

3. Prinsip dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Menurut (Ety Diana Sulistyawati, 2022) Prinsip pengelolaan Program KIA adalah memantapkan dan peningkatan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok:

- a. Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya.
- b. Peningkatan pertolongan persalinan yang ditujukan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional secara berangsur.

- c. Peningkatan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi serta penanganan dan pengamatannya secara terus menerus.
- d. Peningkatan pelayanan neonatal (bayi berumur kurang dari 1 bulan) dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi tingginya.

4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Menurut (Ety Diana Sulistyawati, 2022) Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan antenatal

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Standar minimal "20 T " untuk pelayanan antenatal terdiri dari:

- 1) Tanyakan bantuan apa yang dapat dibeikan dan tanyakan dengan ramah.
 - a) Identitas ibu lengkap,
 - b) Riwayat kesehatan keluarga,
 - c) Riwayat kesehatan ibu hamil,
 - d) Riwayat kehamilan terdahulu,
 - e) riwayat persalinan terdahulu,
 - f) riwayat kehamilan sekarang
 - g) Tanyakan gejala PMS
- 2) Timbang BB dan ukur tinggi badan
 - a) Rambut, telinga, hidung
 - b) Daerah muka (conjungtiva, bibir, mulut)
 - c) Leher (vena yugularis externa, kelenjar tiroid, kelenjar submandibula dan retroauricular)
 - d) Trakhea
- 3) Tentukan/ ukur
 - a) Frekuensi nadi
 - b) Frekuensi pernafasan
 - c) Lingkar lengan atas
 - d) Tekanan darah
- 4) Temukan kelainan (PALPASI)
 - a) Payudara
 - b) Liver
 - c) Limpa (daerah endemis malaria)
 - d) Ginjal

- 5) Tentukan/ periksa
 - a) Tinggi fundus uteri
 - b) Posisi janin
 - c) Denyut jantung janin
- 6) Tekan/ tes
 - a) Edema tungkai
 - b) Reflek lutut
- 7) Temukan kelainan pada organ luar genetalia dan sekitarnya (sesuai indikasi)
 - a) Apakah Ada Kelainan Kulit Vulva dan Sekitarnya
 - b) Apakah Ada Keluar Cairan dari Vagina (Bentuk, Warna, Bau, Jumlah, Kapan?)
- 8) Tentukan kelainan pada organ bagian dalam genetalia (dinding vagina, portio) (sesuai indikasi)
- 9) Tes laboratorium rutin
 - a) Hb, leukosit, Trombosit
 - b) Urin Lengkap terutama glukosa dan protein urin
 - c) Hepatitis B (HbsAg)
- 10) Tes laboratorium khusus (sesuai indikasi)
 - a) VDRL
 - b) Sediaan duh tubuh
- 11) Tes IVA (sesuai indikasi)
- 12) Tetanus toxoid imunisasi
- 13) Terapi anemia sesuai hasil tes (bila HB > 11 gr %, berikan Fe+asam folat 90 tablet untuk 3 bulan, 1 tablet/ hari). Bila Hb < dari 11 gr %, tablet fe + asam folat diberikan terus sampai Hb > 11 gr %
- 14) Tentukan factor resiko
- 15) Tes HIV sesuai indikasi (VCT)
- 16) Tunjukkan (peragakan)
 - a) Perawatan payudara
 - b) Senam payudara
 - c) Senam hamil (pada kehamilan 28 minggu)
 - d) Inisiasi menyusui dini (IMD)
 - e) Terapkan /Peragakan Pijat Perineum (Mulai Kehamilan 35 Minggu) bila tidak ada kontraindikasi
- 17) Tunjukkan/ peragakan cara akupresur
 - a) Pengurangi Mual
 - b) Payudara Untuk Produksi Asi (Pada Trimester Ke-3)
 - c) Mempercepat "Pembukaan" (Pada saat Inpartu)

- 18) Tunjukkan bimbingan *hypnobirthing*, *brain booster* oleh provider yang terlatih
 - 19) Temu wicara/ penyuluhan dan KONSELING menggunakan BUKU
- b. Frekuensi kunjungan ibu hamil yang optimal adalah 14 kali, yaitu:
- 1 (satu) kali sebulan mulai kehamilan bulan pertama s/d bulan ke 6 (enam), dan 2 (dua) kali sebulan mulai kehamilan 7 (tujuh) bulan s/d 8 (delapan) bulan serta 1 (satu) kali seminggu mulai kehamilan 9 (sembilan) bulan sampai melahirkan.
- c. Dalam rangka memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada ibu, perlu diterapkan prinsip dasar komunikasi dalam pelayanan (17 S) sebagai berikut:
- 1) Salam
 - 2) Sapa
 - 3) Senyum
 - 4) Sabar
 - 5) Selalu menatap mata klien ketika berbicara atau mendengarkan
 - 6) Selalu mengucapkan terima kasih, klien sudah mau datang untuk diperiksa
 - 7) Selalu menanyakan apa saja yang dapat dibantu untuk klien
 - 8) Selalu mendengarkan dengan empati terhadap kata-kata atau keluhan klien
 - 9) Selalu menjelaskan tiap jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan prosedur tiap jenis pemeriksaan, guna pemeriksaan yang akan dilakukan
 - 10) Selalu menanyakan apakah klien sudah memahami prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan
 - 11) Selalu meminta ijin untuk melakukan tiap pemeriksaan
 - 12) Selalu menjelaskan hasil tiap pemeriksaan
 - 13) Selalu menanyakan apakah ada yang ingin ditanyakan oleh klien
 - 14) Selalu memberikan jawaban dengan perlahan- sabar-senyum dan menatap mata klien
 - 15) Selalu mendoakan agar klien cepat sembuh/lebih sehat bila semua pemeriksaan sudah berakhir
 - 16) Selalu mengingatkan klien untuk datang untuk pemeriksaan ulang/bila memerlukan pelayanan kesehatan
 - 17) Selalu mengucapkan untuk berhati-hati di jalan dan selamat jalan sampai tujuan
- d. Pertolongan Persalinan
- Jenis tenaga yang memberikan persalinan pertolongan kepada masyarakat:
- 1) Tenaga profesional dokter spesialis kebidanan, umum, pembantu bidan dan perawat, dokter bidan yang lulus. Sedangkan dukun bayi tidak
 - 2) Deteksi dini ibu hamil berisiko

- 3) Dukun bayi: Terlatih ialah dukun bayi yang telah mendapatkan latihan tenaga kesehatan
dinyatakan terlatih ialah dukun bayi yang belum pernah dilatih oleh tenaga kesehatan atau dukun bayi yang sedang dilatih dan belum dinyatakan lulus.
- e. Faktor risiko pada ibu hamil diantaranya adalah:
 - 1) Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.
 - 2) Anak lebih dari 4
 - 3) Jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang kurang 2 tahun atau lebih dari 10 tahun
 - 4) Tinggi badan kurang dari 145 cm. Berat badan kurang dari 38 kg atau lingkaran atas kurang dari 23,5 cm
 - 5) Riwayat keluarga menderita kencing manis, hipertensi dan riwayat cacat kongenital.
 - 6) Kelainan bentuk tubuh, misalnya kelainan tulang belakang atau panggul. Risiko tinggi kehamilan merupakan keadaan penyimpangan dan normal yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun bayi.
- f. Risiko tinggi pada kehamilan meliputi:
 - 1) Hb kurang dari 8 gram %
 - 2) Tekanan darah tinggi yaitu sistole lebih dari 140 mmHg dan diastole lebih dari 90 mmHg
 - 3) Oedema yang nyata
 - 4) Eklampsia
 - 5) Pendarahan pervaginaan
 - 6) Ketuban pecah dini
 - 7) Letak lintang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu.
 - 8) Letak sungsang pada primigravida
 - 9) Infeksi berat atau sepsis
 - 10) Persalinan premature
 - 11) Kehamilan ganda
 - 12) Janin yang besar
 - 13) Penyakit kronis pada ibu antara lain Jantung, paru, ginjal
 - 14) Riwayat obstetri buruk, riwayat bedah sesar dan komplikasi kehamilan.
- g. Risiko tinggi pada neonatal meliputi:
 - 1) BBLR atau berat lahir kurang dari 2500 gram
 - 2) Bayi dengan tetanus neonatorum
 - 3) bayi baru lahir dengan asfiksia

- 4) Bayi dengan ikterus neonatorum yaitu ikterus lebih dari 10 hari setelah lahir
 - 5) Bayi baru lahir dengan sepsis
 - 6) Bayi lahir dengan berat lebih dari 4000 gram
 - 7) Bayi preterm dan post term
 - 8) Bayi lahir dengan cacat bawaan sedang
 - 9) Bayi lahir dengan persalinan dengan tindakan
- h. Jenis Indikator Kesehatan Ibu dan Anak
- Terdapat 6 indikator kinerja penilaian standar pelayanan minimal atau SPM untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak yang wajib dilaksanakan yaitu:
- 1) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Pengertian
Kunjungan ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang kontak dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar 5T dengan frekuensi kunjungan minimal 4 kali selama hamil, dengan syarat trimester I minimal 1 kali, trimester II minimal 1 kali dan trimester III minimal 2 kali.
Standar 5T yang dimaksud adalah:
 - a) Pemeriksaan atau pengukuran tinggi dan berat badan
 - b) Pemeriksaan tekanan darah atau pengukuran
 - c) Pemeriksaan atau pengukuran tinggi fundus
 - d) Pemberian imunisasi TT
 - e) Pemberian tablet besi
 - 2) Definisi operasional
Perbandingan antara jumlah ibu hamil yang telah memperoleh ANC sesuai standar K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan penduduk sasaran ibu hamil.
Cara perhitungan: Pembilang adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC sesuai standar K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
 - 3) Sumber data
Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan ANC sesuai standar K4 diperoleh dari catatan register kohort ibu dan laporan PWS KIA. Perkiraan penduduk sasaran ibu hamil diperoleh dari Badan Pusat Statistik diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS kabupaten atau provinsi Jawa Barat.
 - 4) Mengukur mutu pelayanan ibu hamil
 - 5) Mengukur tingkat keberhasilan perlindungan ibu hamil melalui pelayanan standar dan paripurna. Jumlah ibu yang telah memperoleh pelayanan ANC

sesuai standar K4 Perkiraan penduduk hamil mengukur kinerja petugas kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan ibu hamil

i. Faktor yang mengakibatkan kesehatan ibu terganggu:

1) Kematian ibu (dari masa kehamilan hingga melahirkan)

Faktor kemiskinan dan kesehatan sang ibu akan berdampak bagi calon buah hati yang akan terlahir.

Pada kondisi masyarakat yang miskin dan kesehatan sang ibu kurang diperhatikan maka sang ibu dapat beresiko akan kematian, karena berbagai hal yang tidak terduga dapat saja terjadi di masa-masa kehamilan hingga persalinan.

2) Pola hidup tidak sehat

Ibu yang berada dilingkungan tidak sehat dalam artian lingkungan yang kumuh, serta di imbangi dengan kebiasaan yang buruk (merokok dan meminum minuman keras) akan merugikan diri dan buah hati yang berada dalam kandungan.

3) Minimnya perawatan prenatal

Perawatan prenatal merupakan perawatan sebelum melahirkan. Dalam perawatan prenatal dapat meliputi perawatan medis dan pendidikan, sosial serta adanya layanan gizi selama masa kehamilan. Jika seorang ibu kurang mendapat perawatan prenatal maka dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan ibu dan calon buah hati. Perawatan prenatal sebaiknya harus diperhatikan semenjak awal kehamilan.

j. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Pengertian Program Kesehatan Ibu dan Anak

Suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan Lansia. Target Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):

1) Target program adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat pada tahun dalam program gizi serta kesehatan ibu dan anak.

2) Ibu hamil mendapat pelayanan Ante Natal Care (KIA) sebesar 100%.

3) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90%.

4) Cakupan peserta KB aktif sebesar 65%.

5) Pelayanan kesehatan bayi sehingga kunjungan neonatal pertama (KNI) sebesar 90% dan KN Lengkap (KNI, KN2, dan KN3) sebesar 88%.

6) Pelayanan kesehatan anak Balita sebesar 85%.

- 7) Balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya (D/S) sebesar 85%).
- 8) ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan sebesar 80%.
- 9) Rumah Tangga yang mengonsumsi Garam Beryodium sebesar 90%.
- 10) Ibu hamil mendapat 90 Tablet Tambah Darah sebesar 85% dan Balita usia 6-59 bulan mendapatkan Kapsul Vitamin A sebanyak 85%.
- 11) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap kepada bayi 0- 11 bulan sebesar 90%.
- 12) Penguatan Imunisasi Rutin melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional (GAIN) UCI, sehingga desa dan kelurahan dapat mencapai Universal Child Immunization (UCI) sebanyak 100%.
- 13) Pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya Desa dan Kelurahan Siaga aktif sebesar 80%

C. Kondisi Umum Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

Satu dari delapan agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Untuk pencapaian transformasi sosial Indonesia, terdapat tiga misi yang ingin dicapai, diantaranya kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Penetapan misi tersebut berangkat dari peluang Indonesia yang sedang mengalami bonus demografi, di mana populasi usia produktif (15–64 tahun) berjumlah besar dan dapat menjadi mesin pembangunan bangsa. Untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi tersebut, diperlukan investasi pada generasi muda yang dapat mencapai potensi penuh sehingga dapat berkualitas, produktif dan mampu bersaing sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan membangun bangsa. (badan pusat statistik, 2024)

Anak yang sehat sebagai generasi penerus bangsa dibentuk dari masa kehamilan dan secara langsung dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ibu. Oleh karena itu, perhatian pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 40 disebutkan jika upaya kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas dan berkualitas, serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, setiap ibu berhak memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Sementara upaya kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga tumbuh dan

kembang anak, serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasan bayi dan anak yang dilakukan sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai sebelum berusia 18 tahun.(badan pusat statistik, 2024)

Kesehatan pada masa anak-anak dapat berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental yang akan dirasakan ketika berumur dewasa (*National Research Council and Institute of Medicine, 2004*). Oleh karena itu, prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui tumbuh dan kembangnya merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai pembangunan manusia yang berdaya di masa depan. Investasi yang dikeluarkan oleh suatu negara pada kesehatan, nutrisi, dan pendidikan untuk anak-anak merupakan fondasi dalam pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, anak-anak yang sehat akan menjadi SDM di masa depan yang berkualitas. Peningkatan status kesehatan anak juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko kesakitan penduduk di masa yang akan datang.(Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022)

D. Kualitas Pelayanan dan Pusat pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1. Dasar Hukum, Prinsip Kualitas Pelayanan dan Prinsip Pelayanan, Perkembangan Kualitas Pelayanan dan Prinsip Pelayanan

Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa hamil, persalinan dan sesudah melahirkan, penyelenggara pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual adalah bukti kesungguhan pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Upaya peningkatan kelangsungan dan kualitas Ibu dan Anak dilakukan dengan pendekatan *continuum of care the life cycle dan continuum of care of pathway*, yang menekankan bahwa upaya promotif dan preventif sama pentingnya dengan dengan upaya kuratif dan rehabilitatif pada tiap siklus kehidupan dan pada tiap level pelayanan. Kualitatif pelayanan ini didukung oleh SDM kesehatan yang kompeten dan patuh terhadap standard, kesiapan fasilitas pendukung pelayanan lainnya di samping biaya operasional dan supervisi yang terus menerus *Continuum of care the life cycle* artinya pelayanan yang di berikan pada siklus kehidupan yang dimulai dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa hingga lansia. *Continuum of care of pathway* artinya penatalaksanaan yang meliputi tempat pelayanan dan level pencegahan, integrasi program, pembiayaan dan *stakeholder* terkait serta peran dari profesi dan perguruan tinggi. Jika pendekatan intervensi *Continuum of care* ini dilaksanakan maka akan memberi dampak yang signifikan terhadap kelangsungan dan kualitas hidup kesehatan ibu dan anak. Persiapan kesehatan ibu dimulai sejak seorang wanita merencanakan kehamilan, selama masa hamil,

melahirkan, masa nifas dan menyusui, masa menggunakan kontrasepsi keluarga berencana sampai usia lanjut. Sedangkan kesehatan bayi harus diperhatikan sejak janin berada dalam kandungan, selama proses kelahiran, saat bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, masa sekolah hingga remaja (Ety Diana Sulistyawati, 2022)

2. Fokus pelayanan yang diberikan terkait kesehatan ibu dan anak sesuai dengan siklus kehidupannya
 - a. Masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada wanita sebelum hamil terkait dengan keadaan sistem reproduksi, status penyakit menular seksual, keadaan status gizi, masalah penyakit fisik dan psikologis. Kondisi tersebut harus ditindaklanjuti dengan pelayanan yang diberikan berkualitas karena berpengaruh terhadap 1000 hari pertama kehidupan bagi anak yang dimulai sejak masa konsepsi sampai anak balita.
 - b. Seorang Bidan sebagai petugas kesehatan sangatlah penting untuk memperhatikan kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik sejak dalam kandungan sampai masa neonatal melalui pemeriksaan kehamilan yang teratur, pemenuhan gizi ibu hamil termasuk pemberian tablet FE dan Asam Folat. Pemberian imunisasi TT diberikan jika ibu hamil belum memiliki status T5 dan upaya deteksi dini komplikasi kehamilan dan persalinan.
 - c. Pelayanan selama masa nifas dan neonatus berfokus pada upaya inisiasi menyusui dini dan pemberian vitamin K neo. Inisiasi menyusui dini dilakukan sebagai langkah awal pemberian ASI eksklusif dan penggunaan kontrasepsi. Adapun pelayanan neonatus dilakukan melalui pemberian injeksi vitamin K neo pada saat 1 jam pertama kelahiran yang ditujukan untukantisipasi kejadian perdarahan terutama perdarahan pada neonatus yang dapat dipicu akibat penyuntikan imunisasi Hepatitis B neo yang diberikan 2 jam setelah bayi lahir.
 - d. Pelayanan kesehatan bayi, balita dan anak prasekolah difokuskan pada pemberian ASI eksklusif, pemberian imunisasi dasar, pemberian vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, dan pemberian imunisasi booster, serta manajemen terpadu (MTBS) jika bayi dan balita mengalami sakit.
 - e. Pelayanan anak sekolah dan remaja diberikan dengan tujuan untuk melakukan upaya deteksi dini tumbuh kembang anak sekolah melalui skrining/penjaringan anak sekolah dan remaja, konseling gizi HIV/ AIDS NAPZA dan upaya kesehatan sekolah, diberikan pelayanan kesehatan reproduksi untuk membekali para remaja supaya memiliki pengetahuan yang cukup tentang

proses reproduksi yang menjadi tanggung jawabnya.(Ety Diana Sulistyawati, 2022)

E. Upaya Meningkatkan kelangsungan Hidup ibu dan Anak

Kelangsungan hidup ibu dan anak merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara. Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi menunjukkan perlunya intervensi komprehensif melalui pendekatan continuum of care, yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sejak pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga masa anak (Unicef, 2021)

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Peningkatan kelangsungan hidup ibu dilakukan melalui pelayanan antenatal care (ANC) yang berkualitas, persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta pelayanan postnatal care (PNC). Pelayanan yang berkualitas dapat mendeteksi dini komplikasi kehamilan dan mencegah kematian ibu akibat perdarahan, hipertensi, dan infeksi (World Health Organization, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, 2019)

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak

Upaya peningkatan kelangsungan hidup bayi dan anak meliputi pelayanan neonatal esensial, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, serta penanganan penyakit penyebab utama kematian anak seperti pneumonia dan diare (UNICEF, 2021)

3. Perbaikan Status Gizi Ibu dan Anak

Masalah gizi, terutama anemia pada ibu hamil dan stunting pada anak, berkontribusi signifikan terhadap risiko kematian ibu dan anak. Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui suplementasi zat besi dan asam folat, pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, serta intervensi gizi spesifik dan sensitif

4. Penguatan Sistem Rujukan dan Fasilitas Kesehatan

Sistem rujukan maternal dan neonatal yang efektif sangat penting dalam menurunkan risiko kematian akibat keterlambatan penanganan kegawatdaruratan

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Kesehatan

Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan, keterlibatan kader, serta peningkatan peran keluarga dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak

6. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah

Komitmen pemerintah melalui kebijakan nasional, pembiayaan kesehatan, dan integrasi program KIA dengan SDGs menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2020b)

F. Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Bappenas, 2020). Kebijakan dan strategi nasional di bidang kesehatan disusun sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan serta sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (Norris, M., Burke, E., Comaskey, F., 2025).

Kebijakan nasional pembangunan kesehatan di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN. Kebijakan ini menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif, penguatan sistem kesehatan, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional (Fauzi F.Z, 2025).

Strategi nasional pembangunan kesehatan mencakup penguatan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan mutu dan pemerataan layanan, transformasi pembiayaan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi kesehatan. Studi menunjukkan bahwa transformasi sistem kesehatan nasional memerlukan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti ilmiah (Nurmidin.M.F, 2026).

Implementasi kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan akses antarwilayah, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, serta meningkatnya beban penyakit tidak menular. Upaya pemerataan akses layanan melalui Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu strategi utama pemerintah (Olyvia, N., Yuliawati, S., Tirmizi, A., Hartono, B., & Daud, 2026).

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pembangunan KIA

Kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan mengatur upaya pelayanan Kesehatan yang dapat dijangkau rakyatnya. Masyarakat, dari semua lapisan, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pelayanan kesehatan. Upaya Pemerintah untuk menurunkan angka kematian Ibu serta angka kematian bayi & balita, hanya dapat terwujud bilamana terdapat peran dari berbagai stakeholder terkait seperti halnya peranan dari tenaga Kesehatan (Ep et al., 2025).

Peran dari tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan secara *"continuum"*

of care the life cycle” serta pelayanan tersebut dilaksanakan berdasarkan *“continuum of pathway”* sesuai kebutuhan medis. Intervensi untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kelangsungan dan kualitas ibu dan anak, antara lain:

1. Pada 1.000 hari kehidupan (Scaling up Nutrition), sejak anak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun yang mencakup pemenuhan kebutuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, dan stimulasi pertumbuhan perkembangan anak;
2. Persalinan di fasilitas kesehatan;
3. Penguatan keluarga pada pola asih, asah, dan asuh, peningkatan pengetahuan dan keterampilan deteksi dini anak sakit dan bermasalah, dan pencaharian pertolongan pelayanan kesehatan serta menghindari perkawinan dan kehamilan di usia remaja, dan
4. Memperkuat peran keluarga, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta pendidik dalam kesehatan ibu anak, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (Ep et al., 2025)

H. Simpulan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan karena secara langsung mencerminkan derajat kesehatan masyarakat serta menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi kesehatan ibu sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga kesehatan anak sejak lahir, bayi, balita, dan remaja menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang generasi bangsa. Upaya peningkatan KIA tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif, tetapi menekankan pendekatan promotif dan preventif melalui *continuum of care* yang berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan. Intervensi seperti pelayanan antenatal yang berkualitas, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan neonatal dan balita, pemenuhan gizi, imunisasi, serta edukasi kesehatan terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional dan global, KIA berperan strategis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Oleh karena itu, komitmen lintas sektor, penguatan sistem kesehatan, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

I. Referensi

- Asnawi, R., Jusuf, E. C., Rakhmah, N., Chalid, S. M. T., & Lisal, L. (2025). *Analysis of Factors Influencing the Utilization and Fulfillment of MCH (Maternal and Child Health) Handbook in Gowa Regency , Indonesia. XXVI.*
- badan pusat statistik. (2024). *Profil Kesehatan Ibu dan Anak* (Volume 10). Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Ed.). (2022). *Profil Kesehatan Ibu dan Anak*. Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Ep, E. P. S., Kep, N. S. S., Hermanses, S. S., Sarimin, D. S., Sambo, M., Sihombing, N. H., Kes, M., & Sharfina, D. (2025). *Kesehatan Ibu dan Anak* (M. K. La Ode Alifariki, S.Kep., Ns. (Ed.); Pertama). PT MEDIA PUSTAKA INDO.
- Ety Diana Sulistyawati. (2022). *Kesehatan Ibu dan Anak*. PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fauzi F.Z. (2025). *The evolution of National Health Insurance in Indonesia: Policies, progress, and challenges. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 8(1), 67–78.* <https://doi.org/10.33701/jkp.v8i1.5559>
- Kemenkes RI. (2020a). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar*. Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2020b). *Rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020–2024*. Kemenkes RI.
- Norris, M., Burke, E., Comaskey, F., et al. (2025). *A review of national public health strategies in selected countries. Frontiers in Public Health.* <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1391795>
- Nurmidin.M.F. (2026). *Transformation of Indonesia's national health system: A literature review on policy development and implementation. Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner.*
- Olyvia, N., Yuliawati, S., Tirmizi, A., Hartono, B., & Daud, A. G. (2026). Strategi pemerintah melalui JKN untuk pemerataan akses pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai, 6(3).* <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i3.47753>
- Purnamasari, D., et al. (2021). *Determinants of adolescent reproductive health in Indonesia.*
- umami fitroul siti, dkk. (2022). *Ilmu Kesehatan Ibu dan Anak*. Media Sains Indonesia.
- UNICEF. (2021). *Levels and trends in child mortality. United Nations Children's Fund.*
- United Nation. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable*

Development. United Nation.

World Bank. (2016). *Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health: Disease Control Priorities*. World Bank.

World Health Organization, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, & U. N. (2019). *Population Division*.

World Health Organization & UNICEF. (2021). *Every Newborn Action Plan*. WHO.

J. Glosarium

WHO (World Health Organization)	: Organisasi Kesehatan Dunia di bawah PBB yang menetapkan standar, pedoman, dan kebijakan kesehatan global.
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)	: Dokumen perencanaan pembangunan nasional Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun, termasuk kebijakan dan target pembangunan kesehatan.
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	: Indikator pembangunan yang mengukur kualitas hidup penduduk berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
SDGs (Sustainable Development Goals)	: 17 tujuan pembangunan berkelanjutan global hingga tahun 2030, termasuk peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Stakeholder	: Individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan dan peran dalam suatu program atau kebijakan pembangunan.
ANC (Antenatal Care)	: Pelayanan kesehatan terpadu yang diberikan kepada ibu hamil untuk memantau kesehatan ibu dan janin.
Antenatal	: Masa atau segala hal yang berkaitan dengan kehamilan sebelum persalinan.
KEK (Kekurangan Energi Kronis)	: Kondisi kurang gizi jangka panjang pada ibu hamil yang meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.
PONED	: Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar untuk menangani kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan dasar.
BBL (Bayi Baru Lahir)	: Bayi yang berusia 0–28 hari sejak kelahiran.
Neonatus	: Bayi usia 0–28 hari setelah lahir, terdiri dari neonatus dini dan neonatus lanjut.

Involusi Uteri	: Proses kembalinya rahim ke ukuran dan kondisi sebelum hamil setelah persalinan.
IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	: Proses menyusui yang dimulai dalam satu jam pertama setelah bayi lahir.
Hipotermia	: Kondisi suhu tubuh bayi turun di bawah normal (<36,5°C) yang dapat membahayakan bayi baru lahir.
ASI Eksklusif	: Pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
Hb (Hemoglobin)	: Protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen; digunakan untuk menilai anemia.
Eklampsia	: Kondisi kejang pada ibu hamil atau bersalin akibat preeklamsia berat.
KPD (Ketuban Pecah Dini)	: Pecahnya selaput ketuban sebelum proses persalinan dimulai.
Prematur	: Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu.
Primigravida	: Perempuan yang sedang hamil untuk pertama kalinya.
Post Term	: Kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu.
Continuum of Care	Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terintegrasi, dimulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif untuk menjamin pelayanan yang utuh dan berkelanjutan.
Continuum of Care the Life Cycle	: Pendekatan pelayanan kesehatan berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan manusia, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, termasuk kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan nifas.
Continuum of Care of Pathway	: Pendekatan pelayanan kesehatan berkesinambungan berdasarkan alur pelayanan (pathway), yang mencakup pelayanan di tingkat keluarga, masyarakat, fasilitas kesehatan dasar, hingga rujukan lanjutan secara terkoordinasi.

CHAPTER 3

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN

Anita Setyawati, S.Kep., Ners., M.Kep

A. Pendahuluan

Pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan merupakan pilar fundamental dari sistem kesehatan masyarakat kontemporer. Selama beberapa dekade terakhir, pelayanan kesehatan telah mengalami transformasi mendalam dari model yang didominasi biomedis dan berorientasi pada penyakit menjadi paradigma yang lebih holistik, berfokus pada pencegahan, dan berbasis pemberdayaan. Dalam kerangka kerja yang berkembang ini, tenaga kesehatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai penyedia layanan kuratif; melainkan, mereka diakui sebagai pendidik, fasilitator, advokat, kolaborator, dan agen transformasi sosial.

Promosi kesehatan didefinisikan sebagai proses pemberdayaan individu dan komunitas untuk meningkatkan kendali atas faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan mereka (Atasoy & Kublay, 2017; Koelen & Van Den Ban, 2004). Definisi ini menekankan otonomi, pemberdayaan, partisipasi, dan perubahan struktural. Pendidikan kesehatan mengacu pada proses pembelajaran yang dirancang secara terencana dan sistematis untuk membantu seseorang secara sukarela menerapkan perilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatannya (Atasoy & Kublay, 2017).

Bukti empiris secara konsisten menunjukkan bahwa program promosi kesehatan multilevel—khususnya yang mengintegrasikan pendidikan perilaku, dukungan lingkungan, dan keterlibatan organisasi—menghasilkan peningkatan terukur dalam perilaku gaya hidup, indikator antropometrik, kebugaran fisik, kesejahteraan mental, dan kepuasan kerja (Cheng et al., 2022; Kanchan & Gaidhane, 2023; Koelen & Van Den Ban, 2004). Temuan ini memperkuat peran penting tenaga kesehatan dalam merancang, menerapkan, dan mempertahankan intervensi berbasis bukti di berbagai lingkungan klinis, komunitas, dan tempat kerja.

B. Landasan Konseptual dan Teoretis Pendidikan Kesehatan dan Promosi Kesehatan

1. Evolusi Promosi Kesehatan

Perkembangan historis promosi kesehatan mencerminkan pergeseran paradigma dalam filosofi kesehatan global. Secara tradisional, sistem perawatan kesehatan menekankan diagnosis dan pengobatan penyakit. Kedokteran klinis terutama berfokus pada patofisiologi, perawatan akut, dan intervensi kuratif. Namun, meningkatnya prevalensi penyakit kronis tidak menular, kesenjangan kesehatan yang semakin lebar, transisi demografis, dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan memerlukan pendekatan preventif dan sistemik. Transisi epidemiologis ini mengungkapkan bahwa intervensi biomedis saja tidak cukup untuk mengatasi penentu kompleks kesehatan populasi.

Piagam Ottawa menjelaskan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk membantu individu dan masyarakat agar mampu mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka (Atasoy & Kublay, 2017; Koelen & Van Den Ban, 2004). Konsep ini memperluas makna kesehatan masyarakat, tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan politik. Dalam pandangan ini, kesehatan tidak hanya diartikan sebagai tidak adanya penyakit. Kesehatan dipahami sebagai kondisi yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kualitas perumahan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan pangan, hubungan sosial yang baik, serta kebijakan publik.

Akibatnya, tenaga kesehatan diposisikan ulang bukan hanya sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan dan pendukung transformasi struktural. Tanggung jawab mereka meluas ke bidang-bidang seperti advokasi kebijakan, mobilisasi masyarakat, dan kolaborasi antar sektor. Dengan demikian, promosi kesehatan mengintegrasikan keahlian klinis dengan strategi kesehatan masyarakat, yang mengharuskan para profesional untuk menavigasi baik konseling tingkat individu maupun penentu tingkat makro.

Prinsip-prinsip inti promosi kesehatan meliputi pemberdayaan, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar sektor, kesetaraan, dan keberlanjutan. Pemberdayaan melibatkan peningkatan kapasitas individu dan masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat dan mengendalikan penentu kesehatan. Partisipasi masyarakat menekankan kepemilikan bersama atas inisiatif kesehatan, dengan mengakui bahwa perubahan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan lokal. Kolaborasi antar sektor mengakui bahwa hasil kesehatan dibentuk oleh sektor-sektor di luar perawatan kesehatan, termasuk pendidikan, transportasi,

perencanaan kota, dan tenaga kerja. Kesetaraan memastikan bahwa intervensi memprioritaskan populasi rentan dan mengatasi kesenjangan sistemik. Keberlanjutan berfokus pada dampak jangka panjang daripada hasil jangka pendek.

Prinsip-prinsip ini mendefinisikan ulang peran profesional. Para tenaga kesehatan harus mengembangkan kompetensi dalam komunikasi, kepemimpinan, analisis kebijakan, negosiasi pemangku kepentingan, dan pengembangan kemitraan komunitas di samping kemahiran klinis. Profesional kesehatan modern beroperasi dalam sistem adaptif yang kompleks di mana hasil kesehatan muncul dari interaksi antara faktor perilaku, lingkungan, dan struktural.

2. Membedakan Pendidikan Kesehatan dari Promosi Kesehatan

Pendidikan kesehatan mengacu pada kesempatan belajar terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi untuk perubahan perilaku secara sukarela (Atasoy & Kublay, 2017). Hal ini didasarkan pada teori pembelajaran orang dewasa, psikologi perilaku, dan ilmu komunikasi. Intervensi pendidikan sering menargetkan perilaku berisiko individu seperti merokok, gizi buruk, gaya hidup tidak aktif, atau ketidakpatuhan pengobatan. Teknik yang digunakan dapat mencakup ceramah, sesi konseling, materi cetak, alat audiovisual, dan modul digital.

Pendidikan kesehatan yang efektif mengakui prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, termasuk keterlibatan pengalaman, relevansi dengan konteks pribadi, pendekatan yang berpusat pada masalah, dan penguatan. Tenaga kesehatan harus menilai pengetahuan dasar, konteks budaya, dan kesiapan untuk berubah sebelum merancang intervensi. Efektivitas pendidikan tidak hanya bergantung pada keakuratan informasi tetapi juga pada pembedayaan pesan, kejelasan, dan kompetensi budaya.

Namun, promosi kesehatan meluas melampaui pendidikan individu. Promosi kesehatan mencakup modifikasi lingkungan, perubahan kebijakan organisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa intervensi multi-komponen yang mengintegrasikan pendidikan perilaku dengan dukungan lingkungan dan kelembagaan menghasilkan hasil yang lebih unggul dibandingkan dengan strategi komponen tunggal (Cheng et al., 2022; Koelen & Van Den Ban, 2004). Misalnya, program di tempat kerja yang menggabungkan kelas olahraga, konseling nutrisi, restrukturisasi lingkungan, dan penyesuaian kebijakan organisasi menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam indeks massa tubuh, lingkar pinggang, persentase lemak tubuh, dan ukuran kebugaran fisik (Cheng et al., 2022).

Perbedaan ini menyoroti kompleksitas ekologis perubahan perilaku. Individu mungkin memiliki pengetahuan tentang perilaku sehat namun menghadapi hambatan struktural yang menghambat implementasi. Misalnya, konseling nutrisi mungkin tidak efektif jika pilihan makanan sehat tidak terjangkau secara ekonomi. Demikian pula, promosi aktivitas fisik membutuhkan lingkungan yang aman dan dukungan kelembagaan.

Oleh karena itu, meskipun pendidikan kesehatan merupakan komponen inti dari promosi kesehatan, hal itu tidak cukup jika diimplementasikan secara terpisah. Tenaga kesehatan harus mengadopsi pendekatan ekologis dan berbasis sistem yang menyelaraskan strategi perubahan perilaku individu dengan fasilitasi lingkungan dan penguatan kebijakan. Integrasi di berbagai tingkat pengaruh meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan.

3. Model Perilaku dan Ekologis yang Memandu Praktik

Para profesional kesehatan mengandalkan model teoretis untuk memandu desain, implementasi, dan evaluasi intervensi. Penerapan teori memastikan kejelasan konseptual, meningkatkan kemampuan replikasi, dan memperkuat pengukuran hasil.

Kerangka kerja yang menonjol meliputi *Health Belief Model*, *Social Cognitive Theory*, *Transtheoretical Model*, dan *Ecological Model of Health*. *Health Belief Model* menekankan persepsi kerentanan, persepsi keparahan, persepsi manfaat, dan persepsi hambatan sebagai penentu tindakan pencegahan. Tenaga kesehatan menggunakan model ini untuk menilai persepsi risiko pasien dan menyesuaikan pesan yang sesuai. *Social Cognitive Theory* menyoroti pembelajaran observasional, efikasi diri, harapan hasil, dan determinisme timbal balik. Intervensi sering kali menggabungkan pemodelan, penguatan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan perilaku. *Transtheoretical Model* mengkonseptualisasikan perubahan perilaku sebagai proses yang berkembang melalui tahapan—pra-kontemplasi, kontemplasi, persiapan, tindakan, dan pemeliharaan. Kerangka kerja ini mendukung konseling individual berdasarkan kesiapan. *Ecological Model of Health* mengakui pengaruh multilevel terhadap perilaku, mulai dari faktor intrapersonal hingga hubungan interpersonal, lingkungan organisasi, norma komunitas, dan kebijakan publik.

Intervensi yang menggabungkan peningkatan efikasi diri, penetapan tujuan, umpan balik terstruktur, dan lingkungan yang mendukung telah menunjukkan peningkatan dalam aktivitas fisik dan hasil antropometrik (Cheng et al., 2022; Koelen & Van Den Ban, 2004). Perspektif ekologis lebih lanjut memperkuat kebutuhan akan strategi multilevel yang membahas determinan interpersonal, organisasi, dan kebijakan.

Integrasi teori ke dalam praktik memungkinkan tenaga kesehatan untuk merancang intervensi yang tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga selaras secara strategis dengan prinsip-prinsip ilmu perilaku. Pemrograman yang diinformasikan oleh teori meningkatkan validitas internal dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan kumulatif dalam penelitian kesehatan masyarakat.

4. Promosi Kesehatan Berbasis Bukti

Praktik berbasis bukti merupakan inti dari promosi kesehatan modern. Tinjauan sistematis terhadap program promosi kesehatan di tempat kerja menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik dalam kesejahteraan mental, pengurangan stres, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kepuasan kerja (Kanchan & Gaidhane, 2023). Intervensi multidisiplin yang berlangsung selama 20 minggu telah menghasilkan peningkatan yang terukur dalam berat otot, daya tahan kardiovaskular, komposisi tubuh, dan kebugaran secara keseluruhan di antara tenaga kesehatan (Cheng et al., 2022).

Temuan ini menggarisbawahi bahwa promosi kesehatan harus terstruktur, berkelanjutan, terukur, dan dievaluasi secara analitis. Program yang efektif mencakup penilaian kebutuhan, tujuan yang didefinisikan dengan jelas, pemantauan kesetiaan implementasi, dan evaluasi hasil menggunakan indikator yang divalidasi. Pengukuran kuantitatif—seperti indeks massa tubuh, lingkar pinggang, tekanan darah, dan tes kinerja fisik—memberikan bukti objektif tentang dampaknya. Penilaian kualitatif menangkap kepuasan peserta, pemberdayaan yang dirasakan, dan pengaruh kontekstual.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi dalam perencanaan program, pengumpulan data, interpretasi statistik, dan metodologi peningkatan kualitas. Promosi kesehatan berbasis bukti bukan hanya penyampaian informasi, tetapi juga penerapan sistematis temuan penelitian untuk mengoptimalkan hasil kesehatan. Melalui evaluasi yang ketat dan penyempurnaan berkelanjutan, para profesional kesehatan memastikan bahwa inisiatif pendidikan dan promosi kesehatan tetap responsif, efektif, dan selaras dengan kebutuhan populasi.

C. Pendidikan Kesehatan Klinis dan Pemberdayaan Pasien

1. Pertemuan Klinis sebagai Momen Pembelajaran

Interaksi klinis memberikan peluang penting untuk pendidikan kesehatan. Diagnosis, rawat inap, dan kunjungan tindak lanjut sering kali menciptakan penerimaan yang lebih tinggi terhadap panduan perilaku karena pasien mungkin mengalami peningkatan kerentanan yang dirasakan dan motivasi untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Momen pembelajaran ini mewakili periode

yang penting secara psikologis di mana individu lebih cenderung menilai kembali perilaku gaya hidup dan mempertimbangkan perubahan.

Keterlibatan dokter-pasien yang efektif, yang ditandai dengan responsif, empati, mendengarkan aktif, dan waktu konsultasi yang memadai, meningkatkan hasil pasien (Paterick et al., 2017). Ketika para profesional kesehatan mengalokasikan waktu yang cukup untuk menjelaskan diagnosis, mengklarifikasi rencana perawatan, dan mengeksplorasi kekhawatiran pasien, mereka memperkuat kepercayaan dan aliansi terapeutik. Dimensi relasional perawatan ini bukanlah hal tambahan; hal ini secara langsung memengaruhi kepatuhan, kepuasan, dan hasil klinis.

Penelitian menekankan bahwa kemitraan yang kuat antara penyedia layanan kesehatan dan pasien meningkatkan kepatuhan dan hasil kesehatan jangka panjang (Paterick et al., 2017). Model pengambilan keputusan bersama mendorong transparansi mengenai risiko, manfaat, dan alternatif, memungkinkan pasien untuk menyelaraskan rekomendasi medis dengan nilai-nilai pribadi dan keadaan hidup. Kemitraan semacam itu mengubah pasien dari penerima perawatan pasif menjadi peserta aktif dalam manajemen diri. Dalam kerangka kerja kolaboratif ini, pendidikan bukanlah transmisi informasi satu arah, melainkan pertukaran dinamis di mana pengalaman, preferensi, dan tujuan pasien diintegrasikan ke dalam perencanaan perawatan.

Selain itu, lingkungan klinis itu sendiri dapat distrukturkan untuk memperkuat pesan-pesan pendidikan. Protokol perencanaan pemulangan, pengingat tindak lanjut, dan sesi konseling terstruktur memastikan kesinambungan pembelajaran. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam alur klinis melembagakan pencegahan dalam perawatan rutin daripada memperlakukannya sebagai tambahan opsional.

2. Komunikasi yang Berpusat pada Pasien

Pendidikan yang berpusat pada pasien memprioritaskan pengambilan keputusan bersama dan komunikasi individual. Hal ini mengakui heterogenitas dalam latar belakang budaya, tingkat literasi, kapasitas kognitif, dan konteks psikososial. Komunikasi yang efektif membutuhkan penilaian yang cermat terhadap kesiapan pasien, pemahaman, dan hambatan dalam implementasi.

Strategi utama meliputi penilaian literasi kesehatan, penggunaan bahasa sederhana dan menghindari jargon medis, metode pengajaran ulang untuk mengkonfirmasi pemahaman, alat bantu visual dan alat multimedia, serta teknik wawancara motivasional.

Penilaian literasi kesehatan sangat mendasar. Pasien dengan literasi terbatas mungkin salah menafsirkan instruksi dosis atau gagal mengenali tingkat

keparahan gejala. Metode pengajaran ulang—di mana pasien menyatakan kembali informasi dengan kata-kata mereka sendiri—memungkinkan dokter untuk memverifikasi pemahaman dan segera memperbaiki kesalahpahaman.

Wawancara motivasional merupakan pendekatan yang sangat ampuh untuk memfasilitasi perubahan perilaku. Teknik ini menekankan pertanyaan terbuka, mendengarkan secara reflektif, penegasan, dan penggalian motivasi intrinsik. Alih-alih menghadapi penolakan secara langsung, tenaga kesehatan membimbing pasien dalam mengartikulasikan alasan mereka sendiri untuk berubah. Metode ini selaras dengan praktik berbasis pemberdayaan dan telah dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan dan modifikasi perilaku yang berkelanjutan.

Ketika pasien merasakan kolaborasi, rasa hormat, dan kepekaan budaya, mereka menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam perilaku yang meningkatkan kesehatan. Dukungan organisasi lebih lanjut meningkatkan efektivitas komunikasi; iklim institusional yang mendukung dan memprioritaskan perawatan yang berpusat pada pasien memperkuat hasil perilaku (Kanchan & Gaidhane, 2023). Misalnya, institusi yang memungkinkan waktu konsultasi yang lebih lama dan menyediakan materi pendidikan dalam berbagai bahasa menciptakan kondisi struktural yang kondusif untuk komunikasi yang efektif.

3. Efikasi Diri dan Perubahan Perilaku

Efikasi diri keyakinan pada kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu merupakan penentu utama perubahan perilaku kesehatan (Kanchan & Gaidhane, 2023). Pasien mungkin memahami tindakan yang direkomendasikan namun kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pendidikan klinis yang efektif harus membahas pengetahuan dan kompetensi yang dirasakan.

Intervensi pendidikan yang mengintegrasikan penetapan tujuan, perencanaan bertahap, umpan balik kinerja, dan penguatan positif meningkatkan kepercayaan diri dan kepatuhan pasien. Memecah perilaku kompleks menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola mengurangi beban kognitif dan membangun pengalaman penguasaan. Misalnya, daripada menyarankan perubahan pola makan secara menyeluruh, dokter dapat mendorong penggantian bertahap dengan pilihan yang lebih sehat, disertai dengan pemantauan dan umpan balik.

Tenaga kesehatan harus melampaui instruksi didaktik. Konseling berbasis pemberdayaan memperkuat motivasi internal dan keberlanjutan jangka panjang perubahan perilaku. Pendekatan ini mengakui bahwa peningkatan kesehatan yang berkelanjutan bergantung pada komitmen intrinsik daripada paksaan

eksternal. Dengan mengakui otonomi pasien dan mendukung keterampilan pemecahan masalah, dokter menumbuhkan ketahanan dan kapasitas adaptif.

Selain itu, mengatasi faktor emosional dan psikologis sangat penting. Kecemasan, depresi, dan stres dapat melemahkan kepatuhan terhadap perilaku. Mengintegrasikan dukungan psikososial ke dalam pendidikan klinis meningkatkan efektivitas secara keseluruhan dan selaras dengan prinsip-prinsip perawatan holistik.

4. Peran Perawat dan Tenaga Kesehatan Sejawat

Perawat memiliki posisi unik sebagai pendidik kesehatan garis depan karena kontak pasien yang berkelanjutan dan dekat di lingkungan rawat inap dan rawat jalan. Kehadiran mereka yang terus-menerus memungkinkan penguatan pesan pendidikan, pemantauan pemahaman, dan identifikasi dini hambatan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kendala waktu, tekanan beban kerja, dan pelatihan yang tidak memadai dapat menghambat penyampaian promosi kesehatan yang efektif (Atasoy & Kublay, 2017).

Oleh karena itu, program pengembangan profesional berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat kompetensi dalam konseling, wawancara motivasi, kompetensi budaya, dan teori perubahan perilaku (Atasoy & Kublay, 2017). Pelatihan terstruktur meningkatkan kepercayaan diri dan menstandarisasi kualitas pendidikan di berbagai institusi.

Tenaga kesehatan sejawat termasuk ahli gizi, fisioterapis, apoteker, dan pekerja sosial memberikan keahlian khusus yang memperkaya perawatan multidisiplin (Koelen & Van Den Ban, 2004). Ahli gizi menerjemahkan ilmu gizi ke dalam rencana diet praktis. Fisioterapis merancang program latihan individual. Apoteker memastikan literasi dan kepatuhan pengobatan. Pekerja sosial mengatasi hambatan sosial ekonomi yang memengaruhi implementasi pengobatan. Integrasi interdisipliner ini meningkatkan kelengkapan dan mengatasi berbagai faktor penentu kesehatan.

Model perawatan berbasis tim meningkatkan koordinasi, mengurangi fragmentasi, dan mengoptimalkan hasil pasien. Sistem dokumentasi kolaboratif dan rencana perawatan bersama memastikan konsistensi dalam penyampaian pesan edukasi.

5. Manajemen Penyakit Kronis

Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, asma, dan kondisi kardiovaskular memerlukan manajemen diri yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama. Tidak seperti penyakit akut, kondisi kronis membutuhkan kewaspadaan perilaku yang berkelanjutan, kepatuhan pengobatan, pemantauan gejala, dan penyesuaian gaya hidup.

Program terstruktur yang mengintegrasikan konseling diet, panduan aktivitas fisik, edukasi pengobatan, dan manajemen stres menunjukkan peningkatan pada indikator antropometrik dan fisiologis (Cheng et al., 2022). Program-program ini menyoroti pentingnya penguatan berulang, pemantauan, dan penyesuaian tujuan adaptif.

Tenaga kesehatan harus secara sistematis memasukkan edukasi perilaku ke dalam protokol manajemen penyakit kronis, memastikan kesinambungan dan penguatan di seluruh transisi perawatan. Janji temu tindak lanjut, konsultasi *telehealth*, dan pengingat digital mendukung kepatuhan jangka panjang. Dokumentasi tujuan dan kemajuan pasien meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi yang terukur.

Pada akhirnya, pendidikan kesehatan klinis dan pemberdayaan pasien tidak dapat dipisahkan. Dengan mengintegrasikan konseling yang berlandaskan teori, kolaborasi interdisipliner, dan tindak lanjut terstruktur, tenaga kesehatan memfasilitasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dan peningkatan hasil kesehatan jangka panjang.

D. Promosi Kesehatan Berbasis Komunitas dan Praktik Perawatan Primer

1. Pelayanan Kesehatan Primer sebagai Kontak Pertama

Lembaga pelayanan kesehatan primer merupakan antarmuka awal antara masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan (Atasoy & Kublay, 2017). Sebagai titik kontak pertama, fasilitas pelayanan kesehatan primer memiliki posisi unik untuk mengintegrasikan layanan pencegahan, deteksi dini, pendidikan kesehatan, dan penjangkauan masyarakat ke dalam pemberian layanan rutin. Tidak seperti fasilitas tersier khusus, pelayanan kesehatan primer beroperasi dalam jarak dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, memungkinkan tenaga kesehatan untuk memahami pola kesehatan lokal, praktik budaya, dan hambatan kontekstual.

Konseling pencegahan, program imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, skrining penyakit tidak menular, dan penilaian risiko kesehatan secara rutin dilakukan dalam pelayanan kesehatan primer. Kegiatan-kegiatan ini menciptakan peluang sistematis untuk memberikan pendidikan kesehatan sepanjang siklus hidup. Dengan menanamkan pendidikan ke dalam layanan rutin, lembaga pelayanan kesehatan primer menormalisasi pencegahan sebagai komponen mendasar dari pelayanan kesehatan, bukan sebagai tambahan opsional.

Para profesional di pelayanan kesehatan primer harus memiliki kompetensi tidak hanya dalam diagnosis dan pengobatan klinis tetapi juga dalam komunikasi, penilaian masyarakat, dan konseling perilaku (Atasoy & Kublay, 2017). Peran

mereka meluas melampaui konsultasi individu hingga mobilisasi masyarakat dan advokasi kesehatan. Dalam banyak konteks, penyedia layanan perawatan primer berperan sebagai figur tepercaya yang rekomendasinya memengaruhi norma dan perilaku masyarakat. Modal sosial ini dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan penerimaan vaksinasi, peningkatan gizi, praktik kesehatan ibu, dan pencegahan penyakit kronis.

Selain itu, pengaturan perawatan primer memfasilitasi kesinambungan perawatan. Hubungan jangka panjang antara penyedia layanan dan pasien meningkatkan kepercayaan, meningkatkan efisiensi komunikasi, dan memperkuat kepatuhan terhadap rekomendasi pencegahan. Kesinambungan memungkinkan tenaga kesehatan untuk memantau kemajuan perilaku, memperkuat pesan pendidikan, dan menyesuaikan intervensi sesuai dengan kebutuhan pasien yang terus berkembang.

2. Keterlibatan Masyarakat dan Pendekatan Partisipatif

Promosi kesehatan memperkuat individu dan komunitas secara bersamaan (Atasoy & Kublay, 2017). Meskipun konseling individu sangat penting, perubahan berkelanjutan seringkali membutuhkan tindakan kolektif dan transformasi norma sosial. Pendekatan partisipatif menekankan kolaborasi dengan anggota komunitas daripada memaksakan intervensi yang dirancang secara eksternal.

Keterlibatan masyarakat mendorong kepemilikan lokal, relevansi budaya, dan keberlanjutan. Tenaga kesehatan memfasilitasi proses partisipatif seperti penilaian kebutuhan, diskusi kelompok fokus, dan pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi isu-isu prioritas dan penentu kontekstual. Dengan memasukkan perspektif masyarakat ke dalam perencanaan, intervensi lebih mungkin selaras dengan nilai-nilai lokal dan realitas praktis.

Tenaga kesehatan umumnya memfasilitasi forum komunitas untuk membahas tantangan dan solusi kesehatan, kampanye kesehatan masyarakat yang menargetkan perilaku berisiko, program skrining untuk deteksi dini kondisi kronis, inisiatif berbasis sekolah yang mempromosikan nutrisi dan aktivitas fisik, serta kolaborasi berbasis agama yang membahas topik-topik yang sensitif secara budaya.

Program yang mengintegrasikan perubahan lingkungan, sistem dukungan sebaya, dan keterlibatan kebijakan menunjukkan efektivitas yang lebih unggul dibandingkan dengan upaya pendidikan yang terisolasi (Koelen & Van Den Ban, 2004). Sebagai contoh, mempromosikan aktivitas fisik menjadi lebih berkelanjutan ketika komunitas membangun jalur jalan kaki yang aman, menyelenggarakan sesi latihan kelompok, dan mengadvokasi kebijakan kota yang mendukung. Inisiatif yang dipimpin oleh sesama anggota komunitas

semakin meningkatkan keterlibatan dengan memanfaatkan pengaruh sosial dan pemodelan.

Promosi kesehatan partisipatif juga memperkuat ketahanan komunitas. Ketika komunitas mengembangkan kapasitas pemecahan masalah dan efikasi kolektif, mereka menjadi lebih siap untuk mengatasi tantangan kesehatan yang muncul secara mandiri. Tenaga kesehatan bertindak sebagai fasilitator dan penasihat teknis daripada sebagai pengambil keputusan tunggal, memperkuat filosofi pemberdayaan yang menjadi inti dari promosi kesehatan.

3. Kolaborasi Antarprofesi

Kolaborasi multidisiplin meningkatkan kelengkapan dan efektivitas intervensi. Promosi kesehatan berbasis komunitas seringkali membutuhkan keahlian yang mencakup kedokteran klinis, ilmu gizi, psikologi perilaku, epidemiologi, kesehatan lingkungan, dan pekerjaan sosial. Program yang menggabungkan intervensi olahraga, konsultasi gizi, dan pendidikan perilaku menghasilkan peningkatan signifikan dalam indikator kesehatan yang terukur (Cheng et al., 2022).

Kerja tim antarprofesi mengintegrasikan keahlian klinis, perilaku, dan kesehatan masyarakat, memaksimalkan jangkauan dan keberlanjutan (Koelen & Van Den Ban, 2004). Dokter dapat fokus pada stratifikasi risiko dan manajemen medis, perawat pada konseling dan tindak lanjut, ahli gizi pada perencanaan gizi, praktisi kesehatan masyarakat pada pengawasan populasi, dan tenaga kesehatan masyarakat pada penjangkauan dan keterlibatan. Pembagian kerja ini meningkatkan efisiensi sambil mempertahankan penyampaian layanan terintegrasi.

Kolaborasi yang efektif membutuhkan delineasi peran yang jelas, tujuan bersama, dan mekanisme komunikasi seperti konferensi kasus reguler dan sistem dokumentasi bersama. Pendidikan dan pelatihan antarprofesi mendorong pemahaman bersama tentang kompetensi profesional dan mengurangi fragmentasi.

Tenaga kesehatan masyarakat seringkali memainkan peran yang sangat penting dalam menjembatani lembaga perawatan kesehatan dan komunitas. Keakraban mereka dengan budaya dan bahasa lokal meningkatkan kepercayaan dan memfasilitasi penyebaran pesan kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat memperluas jangkauan sistem perawatan kesehatan formal, khususnya di daerah yang kurang terlayani atau pedesaan.

Model kolaboratif tidak hanya meningkatkan hasil kesehatan tetapi juga meningkatkan kepuasan profesional dan efisiensi organisasi. Ketika para

profesional bekerja secara kohesif menuju tujuan pencegahan bersama, duplikasi diminimalkan dan sumber daya dioptimalkan.

4. Mengatasi Faktor Penentu Sosial Kesehatan

Perilaku kesehatan dibentuk oleh status sosial ekonomi, pendidikan, kondisi pekerjaan, kualitas perumahan, keamanan lingkungan, dan akses ke sumber daya perawatan kesehatan. Promosi kesehatan yang selaras dengan kerangka kerja yang mendukung membutuhkan sensitivitas struktural dan analisis sistemik (Koelen & Van Den Ban, 2004). Fokus secara eksklusif pada tanggung jawab individu tanpa mengakui hambatan struktural berisiko melanggengkan ketidakadilan.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mengadopsi strategi ganda yaitu memberikan pendidikan individu sambil mengadvokasi reformasi struktural. Misalnya, konseling diet harus disertai dengan advokasi untuk inisiatif ketahanan pangan, subsidi untuk makanan sehat, atau regulasi pemasaran makanan tidak sehat. Demikian pula, mempromosikan aktivitas fisik membutuhkan ruang publik yang aman dan fasilitas rekreasi yang mudah diakses.

Penyedia layanan perawatan primer berada pada posisi strategis untuk mengidentifikasi faktor penentu sosial yang memengaruhi populasi pasien mereka. Skrining untuk kerawanan pangan, ketidakstabilan perumahan, hambatan transportasi, dan kesulitan keuangan memungkinkan rujukan yang tepat sasaran ke layanan sosial. Integrasi resep sosial menghubungkan pasien dengan sumber daya komunitas seperti kelompok olahraga, lokakarya pendidikan, atau jaringan dukungan merupakan perluasan praktik klinis yang inovatif.

Advokasi kebijakan merupakan dimensi penting lainnya. Tenaga kesehatan dapat memberikan data dan keahlian profesional untuk perencanaan pemerintah daerah, legislasi kesehatan masyarakat, dan pengembangan kebijakan kelembagaan. Dengan menyajikan bukti kesenjangan kesehatan dan efektivitas biaya strategi pencegahan, mereka memengaruhi perubahan struktural yang lebih luas.

Oleh karena itu, intervensi tingkat komunitas mengintegrasikan pendidikan dengan advokasi kebijakan dan modifikasi lingkungan. Melalui keterlibatan yang berkelanjutan, tenaga kesehatan berkontribusi dalam membangun ekosistem sosial yang lebih sehat yang memfasilitasi perubahan perilaku individu.

Singkatnya, promosi kesehatan berbasis komunitas dan praktik perawatan primer beroperasi secara sinergis untuk memajukan kesehatan populasi. Dengan mengintegrasikan pendekatan partisipatif, kolaborasi interdisipliner, dan

advokasi struktural, tenaga kesehatan bergerak melampaui pengobatan episodik menuju pencegahan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesetaraan.

E. Promosi Kesehatan di Tempat Kerja dan Organisasi

1. Tenaga kesehatan sebagai Penerima Manfaat dan Fasilitator

Tenaga kesehatan sendiri mengalami beban kerja yang tinggi, sistem kerja bergilir, tuntutan emosional, dan stres kerja, yang semuanya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis (Cheng et al., 2022). Ironisnya, para profesional yang bertanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan seringkali beroperasi dalam lingkungan yang membahayakan perilaku kesehatan mereka sendiri. Jam kerja yang panjang, waktu pemulihan yang terbatas, pola makan yang tidak teratur, dan paparan situasi klinis dengan tingkat keparahan tinggi berkontribusi pada kelelahan, kehabisan energi, dan peningkatan risiko kondisi kronis.

Oleh karena itu, program promosi kesehatan di tempat kerja yang menargetkan staf kesehatan dibenarkan secara etis dan bermanfaat secara strategis. Dari perspektif etis, institusi memiliki kewajiban untuk menjaga karyawan. Dari sudut pandang strategis, staf yang lebih sehat menunjukkan peningkatan produktivitas, pengurangan ketidakhadiran, peningkatan moral, dan hasil perawatan pasien yang lebih baik.

Bukti empiris mendukung efektivitas program promosi kesehatan di tempat kerja yang terstruktur. Intervensi multidisiplin selama 20 minggu yang menggabungkan sesi latihan terawasi, konsultasi nutrisi, dan pendidikan perilaku secara signifikan meningkatkan indikator antropometrik—termasuk indeks massa tubuh, lingkar pinggang, dan komposisi tubuh—serta hasil kebugaran fisik di antara tenaga kesehatan (Cheng et al., 2022). Peningkatan yang terukur ini menunjukkan bahwa program komprehensif dapat menghasilkan manfaat fisiologis yang nyata bahkan dalam lingkungan kerja yang menuntut tinggi.

Selain itu, intervensi di tempat kerja dalam institusi perawatan kesehatan memiliki nilai simbolis. Ketika tenaga kesehatan secara nyata terlibat dalam perilaku yang meningkatkan kesehatan, mereka menjadi teladan praktik positif bagi pasien dan masyarakat. Efek pemodelan ini selaras dengan prinsip-prinsip Teori Kognitif Sosial, di mana pembelajaran observasional memperkuat adopsi perilaku. Dengan demikian, tenaga kesehatan berfungsi tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai teladan hidup sehat.

2. Budaya Organisasi dan Kesejahteraan Mental

Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa inisiatif program promosi kesehatan di tempat kerja meningkatkan kesejahteraan mental, mengurangi

tingkat stres, menurunkan angka absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja (Kanchan & Gaidhane, 2023). Hasil ini sangat signifikan di lingkungan perawatan kesehatan, di mana kelelahan dan keletihan emosional sering terjadi. Budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas program kesehatan di tempat kerja.

Budaya organisasi yang mendukung ditandai dengan keterlibatan kepemimpinan, komunikasi yang transparan, pengambilan keputusan partisipatif, dan pengakuan atas kontribusi karyawan. Ketika kepemimpinan secara nyata mendukung inisiatif kesehatan melalui dukungan kebijakan, alokasi sumber daya, dan partisipasi pribadi keterlibatan karyawan meningkat. Sebaliknya, program yang hanya bersifat simbolis atau kurang didukung seringkali gagal mencapai dampak yang berkelanjutan.

Keamanan psikologis di tempat kerja juga memengaruhi kesejahteraan mental. Karyawan yang merasa dihargai dan dihormati lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam program kesehatan. Norma organisasi yang memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja, staf yang memadai, dan penjadwalan yang fleksibel memperkuat upaya pengurangan stres.

Para pekerja layanan kesehatan memiliki peran ganda dalam program promosi kesehatan di tempat kerja, yaitu perancang dan pelaksana yang mengembangkan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi program; serta peserta dan penerima manfaat yang terlibat dalam intervensi dan merasakan manfaat kesehatan secara langsung.

Peran ganda ini menciptakan peluang dan tantangan. Di satu sisi, pengetahuan mendalam tentang tuntutan tempat kerja meningkatkan relevansi program. Di sisi lain, tekanan peran dapat membatasi partisipasi jika tanggung jawab implementasi program bertentangan dengan tugas klinis. Oleh karena itu, institusi harus menyeimbangkan distribusi beban kerja untuk memastikan akses yang adil terhadap manfaat program.

Yang penting, peningkatan kesejahteraan mental melampaui hasil individu. Pengurangan stres dan peningkatan moral berkorelasi dengan peningkatan keselamatan pasien, pengurangan kesalahan medis, dan kualitas perawatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, promosi kesehatan organisasi secara tidak langsung memperkuat kinerja institusional dan hasil pemberian layanan kesehatan.

3. Desain dan Evaluasi Program

Program promosi kesehatan di tempat kerja yang efektif memerlukan perencanaan sistematis yang berlandaskan metodologi kesehatan masyarakat. Komponen penting meliputi penilaian kebutuhan yang komprehensif, tujuan

yang jelas dan terukur, strategi intervensi multi-komponen, pemantauan berkelanjutan dan evaluasi statistik.

Penilaian kebutuhan melibatkan analisis demografi tenaga kerja, risiko pekerjaan, indikator kesehatan, dan preferensi karyawan. Survei, pemeriksaan biometrik, kelompok fokus, dan catatan absensi memberikan data dasar. Menyesuaikan program dengan kebutuhan yang teridentifikasi meningkatkan relevansi dan partisipasi.

Tujuan yang terukur memastikan akuntabilitas. Hasil dapat mencakup pengurangan indeks massa tubuh, peningkatan kapasitas aerobik, penurunan skor stres, atau peningkatan tingkat partisipasi. Menetapkan jangka waktu dan tolok ukur memfasilitasi implementasi yang terstruktur.

Intervensi multi-komponen secara konsisten lebih efektif daripada sesi pendidikan yang terisolasi (Cheng et al., 2022). Misalnya, menggabungkan program aktivitas fisik dengan konseling nutrisi, lokakarya manajemen stres, dan modifikasi lingkungan (seperti pilihan kantin yang lebih sehat) menghasilkan efek sinergis. Penguatan lingkungan mengurangi ketergantungan pada motivasi individu saja. Evaluasi statistik yang ketat memperkuat kredibilitas program. Metode analitis tingkat lanjut, seperti persamaan estimasi umum, memungkinkan peneliti untuk menilai efek longitudinal dan respons spesifik subkelompok (Cheng et al., 2022). Misalnya, analisis dapat mengungkapkan penurunan indeks massa tubuh yang lebih besar di antara pekerja *shift* dibandingkan dengan staf siang hari, yang menginformasikan perbaikan yang ditargetkan. Pengambilan keputusan berbasis data meningkatkan optimasi program dan alokasi sumber daya.

Siklus peningkatan kualitas berkelanjutan rencana, laksanakan, pelajari, bertindak mendukung perbaikan berulang. Mekanisme umpan balik memastikan bahwa program tetap responsif terhadap kebutuhan karyawan dan kondisi organisasi yang berkembang.

4. Keberlanjutan dan Kepemimpinan

Komitmen administratif sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang (Kanchan & Gaidhane, 2023). Inisiatif promosi kesehatan yang hanya mengandalkan antusiasme jangka pendek seringkali menghilang setelah pendanaan awal atau perhatian kepemimpinan berkurang. Institusionalisasi membutuhkan integrasi ke dalam kebijakan organisasi, penganggaran, dan perencanaan strategis.

Keterlibatan kepemimpinan beroperasi di berbagai tingkatan: dukungan eksekutif, fasilitasi manajemen menengah, dan advokasi lini depan. Para pemimpin memengaruhi norma budaya dengan mencontohkan partisipasi dan

mengalokasikan waktu khusus untuk keterlibatan program. Integrasi kebijakan—seperti memasukkan indikator kesehatan ke dalam metrik kinerja—menandakan prioritas institusional.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mengembangkan kompetensi dalam kepemimpinan, manajemen program, peningkatan kualitas, dan advokasi kebijakan. Profesional promosi kesehatan yang efektif memahami proses penganggaran, perolehan hibah, negosiasi pemangku kepentingan, dan pelaporan evaluasi. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk mengamankan sumber daya dan mempertahankan inisiatif di luar fase percontohan.

Keberlanjutan juga bergantung pada kepemilikan karyawan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan staf dalam perencanaan dan pengambilan keputusan meningkatkan komitmen dan kelangsungan jangka panjang. Juara sebaya dan komite kesehatan mendorong keterlibatan akar rumput.

Terakhir, keselarasan dengan misi institusional yang lebih luas memperkuat keberlanjutan. Membingkai program promosi kesehatan di tempat kerja sebagai bagian integral dari keselamatan pasien, ketahanan tenaga kerja, dan keunggulan organisasi memastikan koherensi strategis. Ketika promosi kesehatan tertanam dalam identitas institusional, ia beralih dari program perifer menjadi prioritas operasional inti.

Kesimpulannya, program promosi kesehatan di tempat kerja dan organisasi merupakan investasi strategis baik dalam kesejahteraan karyawan maupun kinerja institusional. Melalui desain berbasis bukti, evaluasi yang ketat, budaya yang mendukung, dan kepemimpinan yang berkomitmen, organisasi perawatan kesehatan dapat menumbuhkan lingkungan yang mendukung perilaku yang meningkatkan kesehatan dan memperkuat misi kesehatan masyarakat mereka yang lebih luas.

F. Inovasi Digital, Pertimbangan Etika, dan Arah Masa Depan

1. Promosi Kesehatan Digital

Teknologi digital telah secara fundamental mengubah strategi promosi kesehatan. Platform digital memperluas akses ke pendidikan kesehatan dengan menghilangkan hambatan geografis, temporal, dan sosioekonomi. Media sosial, aplikasi seluler, platform telemedisin, dan portal pendidikan daring memfasilitasi penyebaran informasi kesehatan yang cepat kepada beragam populasi (Stellefson et al., 2020). Tidak seperti intervensi tatap muka tradisional, alat digital memungkinkan keterlibatan berkelanjutan di luar lingkungan klinis.

Promosi kesehatan digital memungkinkan komunikasi cepat, keterlibatan interaktif, dukungan sebaya, umpan balik waktu nyata. Komunikasi cepat

memungkinkan lembaga perawatan kesehatan untuk menyebarkan nasihat kesehatan masyarakat, pedoman pencegahan, dan kampanye perubahan perilaku secara efisien. Selama wabah atau ancaman kesehatan yang muncul, platform digital menyediakan kapasitas penjangkauan langsung.

Keterlibatan interaktif membedakan promosi kesehatan digital dari penyampaian informasi pasif. Fitur-fitur seperti jajak pendapat, webinar langsung, bagian komentar, dan sistem perpesanan memungkinkan komunikasi dua arah. Interaksi ini memperkuat dukungan sosial yang dirasakan dan meningkatkan kepatuhan perilaku.

Komunitas dukungan sebaya—yang difasilitasi melalui forum daring atau kelompok jejaring sosial—memperkuat perubahan perilaku melalui pengalaman bersama. Individu yang mengelola penyakit kronis, tujuan penurunan berat badan, atau tantangan kesehatan mental mendapat manfaat dari jaringan dukungan virtual yang menormalkan kesulitan dan mendorong akuntabilitas.

Umpan balik waktu nyata, yang dimungkinkan oleh perangkat yang dapat dikenakan dan aplikasi pelacakan seluler, meningkatkan pemantauan diri. Penghitung langkah, monitor detak jantung, pelacak glukosa, dan sistem pencatatan diet memungkinkan individu untuk menerima penguatan perilaku langsung. Bukti menunjukkan bahwa umpan balik langsung meningkatkan pengaturan diri dan keterlibatan yang berkelanjutan.

Namun, ekspansi digital menimbulkan risiko yang signifikan. Informasi yang salah menyebar dengan cepat melalui ruang daring yang tidak diatur, berpotensi merusak panduan berbasis bukti. Tenaga kesehatan harus mengatasi informasi yang salah secara proaktif dengan menyediakan alternatif yang kredibel dan mudah diakses. Risiko privasi juga menghadirkan tantangan etis. Pelanggaran data, pelacakan yang tidak sah, dan pembuatan profil algoritmik mengancam kerahasiaan. Oleh karena itu, promosi kesehatan digital harus mengintegrasikan kesadaran keamanan siber dan prinsip-prinsip tata kelola data yang etis.

2. Meningkatkan Kompetensi Profesional

Transformasi digital dalam promosi kesehatan membutuhkan peningkatan kompetensi profesional. Tenaga kesehatan harus mengembangkan literasi digital, keterampilan advokasi daring, dan kompetensi evaluasi konten kritis (Stellefson et al., 2020). Literasi digital melampaui penggunaan teknologi dasar; ini mencakup pemahaman algoritma platform, metrik keterlibatan, dan strategi komunikasi digital.

Para profesional harus mampu menilai keandalan sumber daring, membedakan bukti yang ditinjau oleh rekan sejawat dari konten anekdot atau yang bias secara komersial. Kompetensi evaluatif ini sangat penting ketika

membimbing pasien yang menemukan klaim kesehatan daring yang saling bertentangan.

Keterampilan advokasi daring sama pentingnya. Tenaga kesehatan semakin berperan sebagai influencer digital dalam batasan profesional. Advokasi digital yang efektif melibatkan penerjemahan bukti medis yang kompleks ke dalam bahasa yang mudah diakses sambil tetap menjaga keakuratan ilmiah. Infografis visual, video edukasi singkat, dan webinar interaktif meningkatkan pemahaman publik.

Lebih lanjut, profesionalisme digital membutuhkan kesadaran akan batasan antara identitas daring pribadi dan profesional. Pedoman etika yang jelas mengenai interaksi pasien di platform media sosial harus dijaga untuk melindungi kerahasiaan dan kepercayaan.

Program pelatihan dalam pendidikan profesi kesehatan harus menggabungkan modul komunikasi digital, keterampilan interpretasi data, dan kompetensi informatika kesehatan. Program pengembangan profesional berkelanjutan juga harus membahas teknologi yang sedang berkembang, termasuk sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan dan platform telemedisin.

3. Prinsip-Prinsip Etika

Promosi kesehatan yang etis tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip bioetika dasar yaitu menghormati otonomi, persetujuan berdasarkan informasi, tidak membahayakan, dan kesetaraan. Menghormati otonomi mengharuskan individu untuk mempertahankan kendali sukarela atas keputusan terkait kesehatan. Intervensi digital harus menghindari strategi desain manipulatif yang mengeksploitasi kerentanan perilaku. Meskipun komunikasi persuasif merupakan inti dari teori perubahan perilaku, paksaan atau penipuan melanggar standar etika.

Persetujuan berdasarkan informasi mencakup pengumpulan data digital. Pengguna harus memahami bagaimana data mereka disimpan, dianalisis, dan berpotensi dibagikan. Kebijakan privasi yang transparan dan mekanisme persetujuan yang mudah diakses sangat penting.

Tidak membahayakan mengharuskan meminimalkan kerugian. Alat kesehatan digital harus berbasis bukti untuk menghindari promosi praktik yang tidak efektif atau tidak aman. Selain itu, bahaya psikologis—seperti distorsi citra tubuh dari perbandingan pelacakan kebugaran—harus dipertimbangkan.

Kesetaraan sangat penting dalam promosi kesehatan digital. Kesenjangan digital tetap ada di berbagai garis sosial ekonomi dan geografis. Individu tanpa akses internet yang andal atau literasi teknologi berisiko mengalami pengucilan.

Oleh karena itu, inisiatif digital harus melengkapi, bukan menggantikan, pendekatan berbasis komunitas dan tatap muka.

Filosofi pemberdayaan dalam promosi kesehatan menekankan pemberdayaan daripada paksaan (Koelen & Van Den Ban, 2004). Tenaga kesehatan harus menyeimbangkan pesan persuasif dengan rasa hormat terhadap budaya. Penyesuaian budaya pada konten digital memastikan relevansi dan mencegah marginalisasi yang tidak disengaja. Aksesibilitas bahasa, keragaman representasi, dan kepekaan terhadap norma lokal meningkatkan inklusivitas.

4. Hambatan Implementasi

Meskipun menjanjikan, promosi kesehatan digital menghadapi tantangan implementasi. Hambatan umum meliputi keterbatasan waktu, pelatihan yang tidak memadai, dukungan institusional yang terbatas, dan keterbatasan infrastruktur teknologi (Atasoy & Kublay, 2017).

Tenaga kesehatan seringkali mengalami beban kerja klinis yang berat, sehingga waktu yang tersisa untuk inisiatif keterlibatan digital terbatas. Tanpa pengakuan institusional terhadap promosi kesehatan digital sebagai tanggung jawab formal, partisipasi mungkin tetap bersifat sukarela dan tidak konsisten.

Pelatihan yang tidak memadai melemahkan kepercayaan dan kompetensi. Para profesional yang tidak terbiasa dengan analitik digital, algoritma platform, atau protokol keamanan siber mungkin ragu untuk terlibat sepenuhnya. Program pelatihan terstruktur dan model pendampingan dapat mengurangi hambatan ini.

Dukungan institusional yang terbatas—termasuk pendanaan yang tidak memadai, kurangnya infrastruktur teknologi informasi, dan tidak adanya panduan kebijakan semakin membatasi implementasi. Kepemimpinan organisasi harus mengintegrasikan strategi kesehatan digital ke dalam kerangka perencanaan institusional.

Pendidikan profesional berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat kompetensi dan beradaptasi dengan teknologi yang berkembang. Kolaborasi interdisipliner dengan spesialis teknologi informasi dan analisis data dapat meningkatkan kualitas program.

5. Arah Masa Depan

Tren masa depan dalam promosi kesehatan digital menunjukkan peningkatan kecanggihan teknologi dan personalisasi. Perkembangan yang muncul meliputi pelacakan perilaku yang didukung kecerdasan buatan, intervensi digital yang dipersonalisasi, konseling *telehealth*, dan kerangka kerja pencegahan berbasis kebijakan.

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat menganalisis pola perilaku dan menghasilkan wawasan prediktif. Algoritma pembelajaran mesin

dapat mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami perkembangan penyakit kronis berdasarkan tingkat aktivitas, pola makan, atau data biometrik. Intervensi digital yang dipersonalisasi kemudian dapat menyesuaikan frekuensi, nada, dan isi pesan sesuai dengan profil pengguna.

Konseling *telehealth* memperluas akses ke layanan dukungan perilaku, khususnya untuk populasi pedesaan atau yang kurang terlayani. Konsultasi berbasis video memungkinkan kesinambungan perawatan sekaligus mengurangi hambatan logistik.

Kerangka kerja pencegahan berbasis kebijakan dapat menggabungkan sistem pengawasan digital untuk pemantauan kesehatan tingkat populasi. Integrasi dengan basis data kesehatan nasional dapat mendukung deteksi dini dan kampanye pencegahan yang ditargetkan, asalkan perlindungan privasi ditegakkan.

Terlepas dari kemajuan teknologi, keterlibatan humanistik tetap menjadi pusat perhatian. Empati, kepercayaan relasional, dan pemahaman kontekstual tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh algoritma. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mengintegrasikan kompetensi teknologi dengan komunikasi yang penuh kasih sayang.

Kesimpulannya, inovasi digital menghadirkan peluang transformatif untuk promosi kesehatan sekaligus memperkenalkan tantangan etis dan struktural. Implementasi yang berkelanjutan membutuhkan literasi teknologi, kewaspadaan etis, komitmen institusional, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan alat digital dalam kerangka kerja berbasis pemberdayaan, tenaga kesehatan dapat meningkatkan jangkauan perawatan preventif sambil menjaga kesetaraan, otonomi, dan kepercayaan.

G. Simpulan

Tenaga kesehatan memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan di berbagai konteks klinis, komunitas, dan organisasi. Bukti secara konsisten menunjukkan bahwa intervensi terstruktur, multidisiplin, dan bertingkat meningkatkan perilaku kesehatan, indikator fisiologis, kesejahteraan mental, dan hasil organisasi.

Kemitraan pasien dan peningkatan efikasi diri memperkuat hasil klinis. Profesional perawatan primer berperan sebagai pendidik dan advokat garis depan, yang membutuhkan pelatihan berkelanjutan dan dukungan kelembagaan. Platform digital memperluas jangkauan tetapi memperkenalkan tantangan etika dan kompetensi.

Promosi kesehatan berkelanjutan membutuhkan perencanaan berbasis bukti,

kolaborasi antarprofesional, advokasi kebijakan, dan komitmen kepemimpinan. Saat sistem perawatan kesehatan menghadapi tantangan global yang kompleks, tenaga kesehatan harus terus berkembang sebagai pendidik, pemimpin, dan agen transformasi social memajukan pemberdayaan, kesetaraan, dan peningkatan kesehatan populasi.

H. Referensi

- Atasoy, E., & Kublay, G. (2017). Health Education and Health Promotion Skills of Health Care Professionals Working in Family Health Centres. *International Journal of Medical Research & Health Sciences*, 6(3), 22–28.
- Cheng, K.-H., Wu, N.-K., Chen, C.-T., Hsu, C.-Y., Lin, Y.-A., Luo, J. J.-C., Lee, L.-A., & Chuang, H.-H. (2022). Effectiveness and Response Differences of a Multidisciplinary Workplace Health Promotion Program for Healthcare Workers. *Frontiers in Medicine*, 9, 930165. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.930165>
- Kanchan, S., & Gaidhane, A. (2023). Social Media Role and Its Impact on Public Health: A Narrative Review. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.33737>
- Koelen, M. A., & Van Den Ban, A. W. (2004). *Health Education and Health Promotion*. Brill | Wageningen Academic. <https://doi.org/10.3920/978-90-8686-665-6>
- Paterick, T. E., Patel, N., Tajik, A. J., & Chandrasekaran, K. (2017). Improving Health Outcomes Through Patient Education and Partnerships with Patients. *Baylor University Medical Center Proceedings*, 30(1), 112–113. <https://doi.org/10.1080/08998280.2017.11929552>
- Stellefson, M., Paige, S. R., Chaney, B. H., & Chaney, J. D. (2020). Evolving Role of Social Media in Health Promotion: Updated Responsibilities for Health Education Specialists. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), 1153. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041153>

CHAPTER 4

ETIKA DAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN

Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi medis, dan perubahan kebutuhan serta standar masyarakat, cara pengembangan layanan kesehatan di era modern pun ikut berubah. Pandangan tradisional tentang layanan kesehatan sebagai proses penyembuhan semata telah digantikan oleh sistem yang mencakup aspek pencegahan, pengobatan, terapi, dan promosi kesehatan. Karena semakin banyak situasi klinis dan non-klinis, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan profesional dan moral yang baik selain keterampilan teknis yang memadai (Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], 2016).

Institut Kedokteran (IOM) menyatakan pada tahun 2001 bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi pasien dari bahaya dengan mengurangi risiko kesalahan medis dan hasil buruk lainnya. Setiap pekerjaan memiliki dampak langsung pada kehidupan dan martabat manusia, itulah mengapa tenaga kesehatan harus selalu profesional untuk memberikan layanan yang aman, berkualitas tinggi, dan beretika. Studi oleh Epstein dan Street (2011) menemukan bahwa pasien lebih puas dengan layanan kesehatan mereka ketika dokter mendengarkan, berkomunikasi, dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan perawatan mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan harus mencakup etika dan keterampilan.

Dalam beberapa dekade terakhir, layanan kesehatan telah mengalami banyak perubahan. Kini, Pasien menjadi pusat perawatan, berlawanan dengan cara berpikir lama yang hanya fokus pada kekuasaan tenaga kesehatan. Menghormati hak-hak orang, memberi mereka kesempatan untuk berpendapat dalam pengambilan keputusan, dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan berdasarkan kepercayaan adalah bagian penting dari perawatan yang berpusat pada pasien (WHO, 2016). Penting bagi tenaga kesehatan untuk bertindak secara profesional agar prinsip-prinsip etika pendekatan ini, yaitu kebebasan, keadilan, dan kebaikan, dapat terwujud.

Namun, terkadang metode perawatan yang berpusat pada pasien di lapangan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Beberapa hal yang dapat membuat tenaga kesehatan kehilangan fokus pada tugas profesional dan moral mereka adalah beban

kerja yang berat, kurangnya sumber daya, dan terlalu banyak tugas rutin. Oleh karena itu, mungkin ada perbedaan besar antara etika kesehatan dan cara pasien sebenarnya dirawat. Perawatan yang benar-benar berpusat pada pasien merupakan salah satu masalah terbesar dalam sistem kesehatan modern. Untuk mengatasi masalah ini, tenaga kesehatan harus menggabungkan etika profesional dengan keterampilan. Diharapkan tenaga Kesehatan mengikuti standar etika profesional tertinggi saat merawat pasien. Etika profesional ini sangat penting dalam kesehatan karena setiap tindakan memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan rasa hormat pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

Etika profesional berfungsi sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan seperti ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai manusia (Gillon, 1994). Prinsip-prinsip utama etika kesehatan adalah otonomi, kebaikan, tidak merugikan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar etika profesional dalam bidang kesehatan. Konsep otonomi menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan mereka setelah mendapatkan semua informasi yang diperlukan. Berdasarkan prinsip beneficence dan non-maleficence, tenaga kesehatan harus memprioritaskan kesehatan pasien dan tidak melakukan hal yang dapat merugikan mereka. Di sisi lain, konsep keadilan menekankan pentingnya memastikan semua orang memiliki akses yang sama dan adil terhadap perawatan kesehatan berkualitas tinggi (Beauchamp & Childress, 2019).

Tenaga kesehatan menggunakan aturan etika untuk membimbing tindakan mereka dan sebagai standar untuk mengukur seberapa baik mereka menjalankan tugas mereka. Kode etik melindungi baik tenaga kesehatan maupun pasien dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perawatan pasien bertindak secara profesional dan moral. Profesional yang mengikuti kode etik memperoleh dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan (Cruess & Cruess, 2014). Kepercayaan dari masyarakat, atau modal sosial, sangat penting bagi layanan kesehatan. Ketika tenaga kesehatan kuat dalam komitmen mereka terhadap etika profesional dalam melakukan asuhan yang berpusat pada pasien. Di sisi lain, ketika profesional bertindak tidak etis atau tidak mengikuti aturan profesional, hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan membuat layanan menjadi kurang aman bagi pasien. Ini berarti tenaga kesehatan harus melihat kepatuhan terhadap etika profesional sebagai bagian penting dari pekerjaan mereka, bukan sesuatu yang tambahan atau diharapkan dari mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mematuhi etika profesional guna memberikan perawatan yang terampil, adil, dan berpusat pada pasien. Identitas profesional tenaga kesehatan dibentuk oleh moral mereka, yang pada gilirannya mempromosikan rasa tanggung

jawab sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, dan moral.

Sebagai konsep yang multifaset, profesionalisme dalam tenaga kesehatan merujuk pada komitmen moral, perilaku, dan sikap mereka saat melayani pasien dan masyarakat. Menjadi tenaga kesehatan yang terampil tidak hanya berarti memiliki banyak pelatihan medis. Hal ini juga berarti memenuhi standar etika, tanggung jawab, dan kejujuran yang tinggi yang penting bagi citra bidang ini. Karena setiap keputusan yang diambil oleh tenaga kesehatan mempengaruhi keselamatan, penghormatan, dan kesejahteraan pasien, profesionalisme merupakan faktor kunci yang membedakan mereka dari pekerjaan teknis rutin (Cruess, Cruess, & Steinert, 2019).

Profesionalisme di kalangan tenaga kesehatan diyakini terdiri dari beberapa komponen penting. Untuk tetap kompeten dalam pekerjaannya, tenaga kesehatan profesional perlu memahami ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan keperawatan, dan mampu membuat keputusan yang sesuai dengan standar profesional dan kemajuan ilmiah. Memiliki keterampilan yang tepat memang penting, tetapi tenaga kesehatan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan cara yang aman, sesuai, dan berfokus pada pasien. Karena hal ini, setiap orang memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan kesehatan (Epstein & Hundert, 2002).

Dalam bidang kesehatan, profesionalisme tidak hanya berarti menguasai bidangnya dan bertanggung jawab. Hal ini juga berarti memiliki pemahaman dan kejujuran. Profesional kesehatan yang beretika selalu bertindak dengan jujur dan konsisten, bahkan ketika mereka berada di bawah tekanan besar, memiliki konflik kepentingan, atau tidak memiliki sumber daya yang cukup. Hal ini karena itulah yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Di sisi lain, empati berarti tenaga kesehatan dapat melihat pasien mereka sebagai individu unik dengan keyakinan, tujuan, dan pandangan dunia mereka sendiri. Hojat (2016) mengatakan bahwa empati memiliki dua tujuan: meningkatkan hubungan terapi dan memberikan dukungan moral untuk memberikan perawatan yang peduli dan berpusat pada pasien. Penting juga untuk melihat profesionalisme tenaga kesehatan sebagai tugas etis yang berasal dari kontrak sosial antara masyarakat dan bidang kesehatan. Kita mempercayai tenaga kesehatan, memberikan kebebasan profesional kepada mereka, dan mengakui pekerjaan mereka agar mereka dapat menjalankan tugasnya. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral untuk menempatkan kebutuhan pasien dan masyarakat di atas tujuan pribadi, politik, atau finansial mereka. Cara berpikir ini menyatakan bahwa profesionalisme lebih dari sekadar kumpulan keterampilan; itu juga merupakan kewajiban untuk bertindak demi kebaikan orang lain (Cruess & Cruess, 2014).

Sistem kesehatan saat ini didasarkan pada gagasan inti, yaitu memberikan asuhan yang berpusat pada pasien, yang menempatkan pasien di pusat semua aspek perawatan mereka. Menurut gagasan ini, perawatan kesehatan tidak hanya tentang mengobati gejala, tetapi juga tentang memperlakukan orang dengan martabat dan belas kasih, karena setiap orang memiliki prioritas, minat, keyakinan, dan pengalaman hidup yang unik. Pasien dianggap lebih dari sekadar penerima terapi medis; mereka adalah peserta aktif dalam perawatan mereka sendiri dalam paradigma ini. Penyedia layanan kesehatan diharapkan menekankan nilai-nilai manusiawi, tanggung jawab moral, dan kualitas interaksi terapeutik dalam pendekatan berpusat pada pasien, yang pada gilirannya menggabungkan unsur-unsur profesionalisme dan etika (Institute of Medicine [IOM], 2001). Ciri khas perawatan berpusat pada pasien adalah kepatuhan mutlak terhadap otonomi, hak, dan nilai-nilai individu sepanjang pengalaman perawatan kesehatan mereka. Tenaga kesehatan berkewajiban untuk memperlakukan pasien dengan kebaikan dan belas kasih, tanpa bias atau prasangka, serta menghormati hak mereka atas otonomi dan privasi. Agar pasien dapat memiliki peran yang berarti dalam pilihan terkait kesehatan, penting bagi mereka untuk memiliki akses ke informasi yang jujur, jelas, dan mudah dipahami.

B. Etika Profesi dalam Konteks Pelayanan Kesehatan

Etika dalam pelayanan kesehatan adalah kumpulan aturan yang harus diikuti oleh dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya saat merawat pasien. Etika dalam pelayanan kesehatan berasal dari aspek-aspek bidang ini yang secara langsung mempengaruhi kehidupan, keselamatan, dan rasa harga diri seseorang. Karena itu, proses pelayanan kesehatan dipenuhi dengan masalah etika yang mendalam. Pada akhirnya, setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat memiliki dampak moral, sosial, dan hukum terhadap pasien dan masyarakat secara keseluruhan (Beauchamp & Childress, 2019). Tenaga kesehatan diharapkan mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan mulia pekerjaan mereka dengan mengikuti kode etik yang mengatur cara bertindak mereka.

Etika profesional semakin penting dalam membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan sebagai seperangkat aturan tentang cara bertindak. Orang mempercayai tenaga kesehatan ketika mereka yakin bahwa tenaga kesehatan akan melakukan yang terbaik untuk mereka dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, etika profesional sangat penting bagi validitas sosial profesi kesehatan. Masyarakat mempercayai profesi kesehatan dan memberikan kebebasan kepadanya selama anggotanya mengikuti standar moral terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan (Cruess & Cruess, 2014). Etika profesional tidak sama dengan

aturan perilaku umum. Etika umum menetapkan aturan perilaku moral yang harus diikuti oleh semua orang, seperti jujur, adil, dan menghormati orang lain. Etika profesional, di sisi lain, lebih situasional dan spesifik karena dirancang untuk menangani masalah moral unik yang muncul dalam suatu pekerjaan. Ada beberapa aturan etika yang harus diikuti oleh profesional kesehatan yang tidak selalu termasuk dalam etika umum. Misalnya, mereka harus menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati hak pasien untuk membuat pilihan sendiri, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan klinis yang mereka ambil.

Hal ini memungkinkan untuk melihat etika profesional sebagai pengembangan dari etika umum dengan fokus pada tugas-tugas yang khas dalam bidang kesehatan. Etika profesional tidak menggantikan etika umum; sebaliknya, ia memperjelas dan memperluas cara etika umum diterapkan dalam dunia kesehatan yang kompleks dan terkadang berbahaya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang etika profesional agar dapat menjalankan tugasnya dengan menghormati moral, kewajiban sosial, serta martabat dan kemanusiaan setiap individu. Tenaga kesehatan menggunakan prinsip-prinsip etika kesehatan untuk membantu mereka mengambil keputusan dan bertindak secara profesional saat berhadapan dengan pasien. Dalam praktik klinis nyata, tenaga kesehatan bertindak secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar ideal dan alasan praktis untuk perawatan yang berpusat pada pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

C. Prinsip-Prinsip Etika Kesehatan sebagai Landasan Praktik Profesional

Ide otonomi menyatakan bahwa pasien seharusnya dapat membuat keputusan sendiri mengenai perawatan mereka berdasarkan semua pengetahuan yang mereka miliki. Ketika dokter merawat pasien, mereka harus selalu jujur, teliti, dan mudah dipahami. Mereka juga harus menghormati pilihan pasien, meskipun berbeda dengan pilihan mereka sendiri atau anggota keluarga pasien. Tenaga kesehatan dan pasien bekerja sama dalam perawatan yang berpusat pada pasien sebagai hubungan yang setara berdasarkan konsep kebebasan. Praktik seperti kesepakatan yang terinformasi dan pengambilan keputusan bersama menunjukkan bagaimana orang bekerja sama. (Beauchamp & Childress, 2019)

Berdasarkan prinsip beneficence, tenaga kesehatan harus memprioritaskan kesehatan pasien dan berusaha memberikan manfaat kesehatan terbaik bagi mereka. Prinsip ini menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus memberikan pengobatan yang bermanfaat, tidak berisiko, dan dirancang khusus untuk kebutuhan pasien. Selain tindakan terapeutik, tindakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan melalui promosi,

pencegahan, atau keduanya juga dianggap bermanfaat. Dengan kata lain, prinsip ini mewakili kewajiban moral tenaga kesehatan untuk selalu memprioritaskan kebutuhan pasien (Gillon, 1994). Dalam konteks kedokteran, *non-maleficence* berarti berhati-hati dalam pengambilan keputusan, mengendalikan risiko, dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan pasien. Prinsip moral ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan aman dan berstandar tinggi (Beauchamp & Childress, 2019).

Empat landasan etika kesehatan adalah *otonomy*, *benefience*, *non-maleficence*, dan *justice*. Ketika digabungkan, mereka membentuk seperangkat aturan lengkap bagi mereka yang bekerja di bidang medis. Profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan etika merupakan bagian penting dari perawatan yang berpusat pada pasien, itulah mengapa mereka disebut prinsip. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengadopsi konsep etika kesehatan guna menciptakan praktik kesehatan yang baik, aman, adil, dan menghormati.

D. Profesionalisme Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Berpusat pada Pasien

Mencapai perawatan yang berpusat pada pasien, yang menjadi inti dari sistem kesehatan modern, sangat bergantung pada seberapa terampil tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan profesional tidak hanya menunjukkan keahlian teknis. Mereka juga memiliki komitmen moral yang kuat, pandangan etis, dan rasa tanggung jawab sosial dengan memberikan layanan yang melindungi hak-hak pasien dan kemanusiaan. Cruess, Cruess, dan Steinert (2019) menyatakan bahwa keahlian adalah bagian terpenting dari perawatan yang berpusat pada pasien. Hal ini memastikan bahwa semua layanan diberikan dengan penuh perhatian, aman, dan mengutamakan pasien.

Untuk memberikan asuhan yang berpusat pada pasien, tenaga kesehatan harus membangun hubungan yang baik dengan pasien mereka dan memperlakukan setiap orang sebagai individu dengan pandangan, pengalaman, dan keinginan mereka sendiri. Tenaga kesehatan yang terampil dalam konteks ini dapat menunjukkan pemahaman, keterampilan komunikasi yang baik, dan penghormatan terhadap hak pasien untuk membuat keputusan sendiri, di antara hal-hal lain. Epstein dan Street (2011) menyatakan bahwa metode ini merupakan pergeseran dari pendekatan top-down ke pendekatan bottom-up, berpusat pada pasien, dan melibatkan kolaborasi. Selain itu, kewajiban etis tenaga kesehatan dalam membuat keputusan klinis erat kaitannya dengan profesionalisme mereka dalam perawatan berpusat pada pasien. Tenaga Kesehatan juga harus mempertimbangkan situasi sosial pasien, pandangan, dan keyakinan mereka. Dalam asuhan yang berpusat pada pasien, tenaga Kesehatan menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan

pertimbangan moral untuk membuat keputusan yang secara medis tepat dan secara moral benar bagi pasien dan keluarga mereka (Beauchamp & Childress, 2019).

Kepercayaan antara tenaga medis dan pasien akan terjalin jika mereka mengikuti standar etika, perilaku profesional, dan tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kelalaian dapat menyebabkan pasien diperlakukan dengan buruk, kebutuhan mental mereka tidak terpenuhi, dan standar serta keamanan perawatan kesehatan terganggu. Akibatnya, profesionalisme dalam perawatan berpusat pada pasien berarti selalu berpegang pada idealisme moral dan kepedulian (Cruess & Cruess, 2014). Bidang kesehatan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan hal ini tercermin dalam keterampilan anggotanya saat memberikan perawatan berpusat pada pasien. tenaga kesehatan memiliki kebebasan besar untuk membuat keputusan tentang kehidupan orang lain dan layanan yang mereka butuhkan. Dan Penyedia layanan kesehatan memiliki kewajiban untuk mendukung prinsip keadilan, rasa hormat, dan kebaikan dalam pekerjaan mereka, dan mereka juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas perawatan yang mereka berikan. Untuk membuat sistem kesehatan adil dan berkelanjutan, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan, yang juga merupakan kebutuhan pribadi.

E. Etika Profesi sebagai Fondasi Profesionalisme Tenaga Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, tidak ada perbedaan antara etika profesional dan keterampilan. Etika profesional memberikan para pekerja di bidang Kesehatan mempunyai keyakinan dan nilai moral yang membantu mereka memilih cara bertindak dan berpikir yang tepat. Namun, profesionalisme adalah cara mereka menunjukkan keyakinan tersebut kepada orang-orang yang mereka temui dan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan sebagai pekerja setiap hari. Dalam perawatan yang berpusat pada pasien, karakter moral dan rasa tanggung jawab sosial penyedia layanan kesehatan sama pentingnya dengan keterampilan teknis mereka. Hal ini membuat hubungan antara profesionalisme dan praktik etis semakin penting (Cruess, Cruess, & Steinert, 2019). Diharapkan dari tenaga kesehatan untuk memperlakukan pasien dengan penuh perhatian, jujur, dan hormat sebagai bagian dari etika profesional. Etika mengajarkan kepada tenaga kesehatan bahwa mereka tidak boleh menyakiti pasien, bahwa berbuat baik bagi orang lain penting, dan bahwa mereka harus mendukung hak pasien untuk membuat keputusan sendiri. Cara berpikir ini tercermin dalam cara tenaga kesehatan membuat keputusan, berkomunikasi satu sama lain, dan menangani situasi klinis yang sulit dan tidak pasti (Beauchamp & Childress, 2019).

Jujur dalam kehidupan pribadi dan profesional adalah salah satu aspek

terpenting dari profesionalisme. Setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk bertanggung jawab atas segala tindakan mereka terhadap pasien, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, memiliki etika berarti tetap berpegang pada idealisme yang diungkapkan, meskipun ada tekanan dari dalam perusahaan, konflik kepentingan yang mungkin terjadi, atau kekurangan sumber daya. Tanpa landasan moral yang kuat, industri menjadi tidak berguna; itu hanya mengikuti aturan (Cruess & Cruess, 2014). Nilai-nilai etika yang mengarahkan perilaku tenaga kesehatan tercermin dalam cara mereka menjalankan tugasnya. Konsep etika yang kabur dan konvensional dapat diimplementasikan melalui perilaku profesional yang peduli, bertanggung jawab, dan berpusat pada pasien. Oleh karena itu, profesionalisme bukan hanya bersifat teknis, itu adalah pernyataan moral tentang kewajiban profesi kesehatan untuk merawat pasien dengan penuh perhatian (Epstein & Hundert, 2002). Mengintegrasikan etika profesional dan etika ke dalam perawatan yang berpusat pada pasien adalah salah satu hal terpenting yang perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan dan hubungan terapi yang baik. Selain memenuhi standar kualitas dan keamanan, layanan kesehatan yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam pekerjaan sehari-hari mereka menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap keadilan sosial dan nilai-nilai manusia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan harus didasarkan pada etika para tenaga kesehatan.

F. Penguatan Etika Profesi dalam Pendidikan dan Praktik Kesehatan

Karena sistem kesehatan modern begitu kompleks, kita perlu segera meningkatkan etika profesional dalam pendidikan dan praktik kesehatan. Kemampuan teknologi yang baik saja tidak selalu cukup untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul akibat penemuan baru dalam bidang kedokteran, kemajuan ilmu pengetahuan, dan fakta bahwa sistem kesehatan terus berubah. Sebagai cara untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi ilmiah, moral, dan sosial, etika profesional harus diajarkan sejak masa pendidikan hingga masa kerja (Beauchamp & Childress, 2019). Sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mempelajari etika profesional karena hal ini membentuk pandangan dan keyakinan mereka. Pendidikan etika bersifat berkelanjutan dan terstruktur, dan mahasiswa di bidang kesehatan belajar tentang konsep moral, cara memikirkan masalah etika yang mungkin timbul, serta cara menggunakan logika etika. Selain mengajarkan apa yang benar dan salah, tujuan lain dari pendidikan etika adalah mengajarkan mereka cara berpikir kritis dan mengambil keputusan etika dalam situasi klinis yang kompleks.

Profesionalisme, kebaikan, kejujuran, dan etika adalah sifat-sifat yang dapat dipelajari seiring waktu melalui proses berkelanjutan dalam mengintegrasikan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan tempat kerja. Para penulis Cruess, Cruess, dan Steinert (2019) menyatakan bahwa standar etika ditunjukkan di sekolah dan klinik melalui teladan, budaya perusahaan, dan refleksi profesional berkelanjutan. Keterampilan medis penting untuk perawatan yang berpusat pada pasien, tetapi etika profesional sama pentingnya. Tenaga kesehatan perlu mampu menyeimbangkan pengetahuan teknis mereka dengan isu-isu moral dalam semua aspek asuhan pasien, seperti percakapan terapi, pengambilan keputusan bersama, dan menghormati hak-hak pasien serta kemanusiaan mereka. Epstein dan Hundert (2002) menyatakan bahwa jika etika tidak dijadikan keterampilan yang lebih penting, profesionalisme dapat menjadi sekadar mengikuti aturan, yang akan menghilangkan sisi manusiawi dalam perawatan kesehatan.

Oleh karena itu, mempromosikan etika profesional dalam pendidikan dan praktik kesehatan adalah cara yang baik untuk mendorong tenaga kesehatan lebih peduli terhadap pasien. Kualitas pelayanan kesehatan sangat terkait dengan seberapa baik etika profesional dan keterampilan tenaga kesehatan diintegrasikan. Hal ini terutama berlaku saat menggunakan layanan yang berpusat pada pasien. Studi tentang etika kesehatan dan profesionalisme menunjukkan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik dari tenaga kesehatan yang sangat profesional dan memahami etika dengan baik (Epstein & Street, 2011).

Berdasarkan studi yang dilakukan dalam berbagai situasi pelayanan kesehatan, mengikuti prinsip-prinsip etika profesional terkait dengan tingkat kepercayaan dan kepuasan pasien yang lebih tinggi. Beberapa konsep ini meliputi mendukung hak pasien untuk membuat keputusan sendiri, jujur, dan memperlakukan semua orang secara setara. Studi Barry dan Edgman-Levitan (2012) menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang mengutamakan etika lebih mampu membangun hubungan yang terpercaya dengan pasien. Hal ini memungkinkan pasien memiliki peran yang lebih besar dalam keputusan terkait perawatan mereka. Kompetensi, tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan adalah beberapa sifat profesional paling penting bagi tenaga kesehatan yang telah diteliti. Studi kualitatif dan objektif keduanya menunjukkan bahwa empati dan komunikasi yang baik meningkatkan pengalaman pasien, membuat pasien lebih aman, dan membuat mereka lebih patuh pada rencana perawatan mereka. Cruess, Cruess, dan Steinert (2019) mengatakan hal ini menunjukkan bahwa dasar moral praktik kesehatan terkait dengan keahlian.

Selain itu, penelitian di bidang pendidikan dan praktik kesehatan menunjukkan bahwa tenaga kesehatan yang menerima pelatihan profesionalisme dan etika profesional lebih mampu menggunakan pemikiran etis saat menghadapi situasi

klinis yang sulit. Ada bukti bahwa pengajaran etika dengan fokus pada refleksi diri dan pertumbuhan pribadi dapat membantu tenaga kesehatan menjadi lebih terampil dan lebih yakin dalam mengambil tindakan etis dalam perawatan yang berpusat pada pasien (Branch, 2015).

Di sisi lain, beberapa studi menunjukkan keahlian dan etika sulit untuk benar-benar diterapkan di lapangan. Tuntutan administratif, sumber daya yang terbatas, dan beban tugas tenaga kesehatan seringkali membuat penerapan prinsip etika secara optimal menjadi lebih sulit. Kondisi ini dapat menurunkan standar perawatan yang berpusat pada pasien karena dapat menimbulkan kesenjangan antara praktik profesional dan pemahaman etika (Institute of Medicine, 2001).

Data yang dimiliki menunjukkan bahwa tenaga kesehatan harus mampu menggabungkan etika profesional dan keterampilan agar layanan berpusat pada pasien dapat berjalan dengan baik. Data ini menegaskan bahwa jika kita ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan, kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan etika profesional dan perilaku. Tenaga kesehatan dapat menciptakan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berpusat pada pasien jika menggunakan hasil studi ini sebagai dasar untuk saran kebijakan, pendidikan, dan praktik.

G. Kesimpulan

Hal utama yang diperlukan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berpusat pada pasien adalah agar tenaga kesehatan memiliki standar profesional dan keterampilan yang memadai. Etika profesional tidak boleh dipandang sebagai sekumpulan aturan tambahan yang dapat dipilih oleh tenaga kesehatan untuk diikuti, melainkan sebagai sesuatu yang membentuk pikiran, tindakan, dan tanggung jawab mereka dalam setiap aspek asuhan pasien. Aspek lain adalah praktik, yaitu bagaimana standar moral ini diterapkan dalam situasi kesehatan nyata (Cruess, Cruess, & Steinert, 2019). Agar asuhan benar-benar berpusat pada pasien, tenaga kesehatan harus menghormati hak, keinginan, dan rasa martabat pasien sebagai orang yang sedang dirawat.

Bagian buku ini menggunakan argumen teoretis dan studi kasus untuk menunjukkan bagaimana berbagai masalah di bidang kesehatan, seperti kekurangan sumber daya, tekanan struktural, dan konflik kepentingan, menguji kejujuran dan keterampilan tenaga kesehatan. Ketika hal ini terjadi, kesopanan yang didasarkan pada etika menjadi kunci untuk memberikan layanan yang baik dan memperoleh kepercayaan pasien. (Institute of Medicine, 2001). Hasil ini juga menekankan pentingnya menjadikan etika profesional sebagai keterampilan inti bagi tenaga kesehatan, baik dalam pelatihan maupun dalam pekerjaan mereka.

Penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan etika yang juga fokus pada pembentukan karakter dan identitas profesional mereka. Hal ini akan membantu mereka menjadi tenaga Kesehatan dengan moral yang kuat, kebaikan, dan rasa tanggung jawab sosial. Epstein dan Hundert (2002) menyatakan bahwa sistem kesehatan, masyarakat, dan sekolah semua perlu mempertimbangkan cara menggabungkan keterampilan dan etika secara konsisten. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, adil, dan penuh kasih sayang, penting bagi tenaga kesehatan untuk mengintegrasikan etika profesional dan etika dalam memberikan asuhan yang berpusat pada pasien. Selain membantu dalam merumuskan kebijakan, program, dan praktik kesehatan yang berfokus pada pasien, bagian buku ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis yang meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip profesional dan etika.

H. Referensi

- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Cruess, R. L., & Cruess, S. R. (2014). *Professionalism and medicine's social contract with society*. Cambridge University Press.
- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2019). *Teaching medical professionalism: Supporting the development of a professional identity* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., Lloyd, A., Kinnersley, P., ... Barry, M. (2012). Shared decision making: A model for clinical practice. *Journal of General Internal Medicine*, 27(10), 1361–1367. <https://doi.org/10.1007/s11606-012-2077-6>
- Epstein, R. M., & Hundert, E. M. (2002). Defining and assessing professional competence. *JAMA*, 287(2), 226–235. <https://doi.org/10.1001/jama.287.2.226>
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). The values and value of patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100–103. <https://doi.org/10.1370/afm.1239>
- Gillon, R. (1994). Medical ethics: Four principles plus attention to scope. *BMJ*, 309(6948), 184–188. <https://doi.org/10.1136/bmj.309.6948.184>
- Hojat, M. (2016). *Empathy in health professions education and patient care*. Springer.
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academy Press.
- Shanafelt, T. D., Hasan, O., Dyrbye, L. N., Sinsky, C., Satele, D., Sloan, J., & West, C. P. (2015). Changes in burnout and satisfaction with work-life balance in

physicians and the general U.S. working population between 2011 and 2014. *Mayo Clinic Proceedings*, 90(12), 1600–1613. <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2015.08.023>

World Health Organization. (2016). *Framework on integrated, people-centred health services*. WHO Press.

I. Glosarium

IOM : Institute of Medicine

WHO : Organisasi Kesehatan Dunia

PROFIL PENULIS



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat., merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Doktoral pada Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019. Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh. Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar [y2hhHCoAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=y2hhHCoAAAAJ). Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh. Adapun judul judul buku yang telah terbit: Profil Metabolik Remaja, Suami Siaga, Tips ibu hamil dan Pasca bersalin, Analisis Kepuasan pasien melalui Kinerja perawat di RS Pemerintah, Deteksi Dini Resiko Preeklampsia dan Inovasi Tehnologi Kesehatan. Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id

Motto: "Bagikanlah ilmu selama hidup didunia untuk bekal akhiratmu"



Bdn. Septiwiarsi, SST., M.Kes., Penulis Lahir di Tanjung Raja, 28 September 1990, sebagai dosen Prodi DIII Kebidanan STIKes Bhakti Husada Cikarang. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan DIII Kebidanan STIK Bina Husada Palembang, DIV Bidan Pendidik STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta, Strata II STIK Bina Husada Palembang dan Program Studi Profesi Kebidanan di STIKes Medistra Indonesia Bekasi. Mata Kuliah yang di ampuh Promosi Kesehatan Reproduksi Remaja, Dokumentasi Kebidanan, Komunikasi Efektif dalam kebidanan, Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan dan Asuhan Kebidanan Pasca Salin dan Menyusui. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai peneliti yang di publikasikan pada jurnal nasional dan jurnal international.

Penulis dapat dihubungi melalui Email : sseptiwiarsi@gmail.com. **Motto: "Gratitude is the best attitude"**

PROFIL PENULIS



Anita Setyawati, S.Kep., Ners., M.Kep., adalah seorang akademisi, peneliti, dan penulis yang memiliki minat khusus dalam bidang Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis, Edukasi dan Promosi Kesehatan, serta Terapi Komplementer. Penulis lahir di Cirebon, 03 Oktober 1988. Ia menempuh pendidikan Sarjana Keperawatan pada tahun 2006 dan Profesi Ners pada tahun 2010 di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Kemudian melanjutkan studi Magister Keperawatan pada tahun 2011 di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan Konsentrasi Keperawatan Kritis. Penulis mengawali karirnya sebagai Dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dan saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon. Melalui buku yang ditulisnya, ia berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya edukasi dan promosi kesehatan sebagai bagian dari pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anita.setyawati@unpad.ac.id dan anitasetyawati03@gmail.com.



Bdn. Yanti, S.SiT., M.Keb., Lahir di Jambi, 07 Mei 1977. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Kesdam II/SWJ Cabang Jambi tahun 1996. Penulis melanjutkan Diploma III Kebidanan Akademi Kebidanan Poltekkes Jambi tahun 2003. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2006. Dan Lulus Magister Kebidanan Universitas Andalas Padang tahun 2015. Saat ini penulis sebagai Dosen di Prodi Profesi Kebidanan dan aktif mengajar di Universitas Senior Medan. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan. Email: afriwanyanti@gmail.com
Motto "Teruslah Belajar Tak Perduli Berapa Usiamu, Orang Sukses adalah Orang Yang Selalu Ingin Belajar "

Sinopsis

Bunga rampai *"Isu dan Praktik Kesehatan Terkini dalam Perspektif Tenaga Kesehatan"* menghadirkan kumpulan pemikiran, kajian ilmiah, serta refleksi praktik dari berbagai disiplin tenaga kesehatan dalam merespons dinamika permasalahan kesehatan di Indonesia. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan profesional dalam memahami tantangan kesehatan kontemporer sekaligus menawarkan pendekatan strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan diawali dengan analisis mengenai isu kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini, termasuk tantangan beban ganda penyakit menular dan tidak menular, permasalahan gizi, kesehatan lingkungan, serta ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Perspektif ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan intervensi kesehatan.

Selanjutnya, buku ini menyoroti kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional. Berbagai strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal dibahas secara mendalam. Peran tenaga kesehatan dalam pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi fokus penting dalam upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Topik berikutnya mengangkat peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan. Tenaga kesehatan diposisikan tidak hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai komunikator, fasilitator, dan agen perubahan perilaku sehat di masyarakat. Peningkatan literasi kesehatan, pemberdayaan komunitas, serta penguatan strategi komunikasi kesehatan menjadi bagian integral dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sadar kesehatan.

Sebagai landasan praktik profesional, aspek etika dan profesionalisme tenaga kesehatan turut dibahas secara komprehensif. Nilai-nilai integritas, tanggung jawab, empati, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi pilar utama dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Profesionalisme yang kuat diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dan praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kesehatan, serta pemangku kebijakan. Buku ini tidak hanya menggambarkan isu dan tantangan, tetapi juga menghadirkan perspektif solutif guna memperkuat peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Bunga rampai “Isu dan Praktik Kesehatan Terkini dalam Perspektif Tenaga Kesehatan” menghadirkan kumpulan pemikiran, kajian ilmiah, serta refleksi praktik dari berbagai disiplin tenaga kesehatan dalam merespons dinamika permasalahan kesehatan di Indonesia. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan profesional dalam memahami tantangan kesehatan kontemporer sekaligus menawarkan pendekatan strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan diawali dengan analisis mengenai isu kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini, termasuk tantangan beban ganda penyakit menular dan tidak menular, permasalahan gizi, kesehatan lingkungan, serta ketimpangan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Perspektif ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan intervensi kesehatan.

Selanjutnya, buku ini menyoroti kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional. Berbagai strategi untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, pencegahan stunting, serta peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal dibahas secara mendalam. Peran tenaga kesehatan dalam pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi fokus penting dalam upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Topik berikutnya mengangkat peran tenaga kesehatan dalam edukasi dan promosi kesehatan. Tenaga kesehatan diposisikan tidak hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai komunikator, fasilitator, dan agen perubahan perilaku sehat di masyarakat. Peningkatan literasi kesehatan, pemberdayaan komunitas, serta penguatan strategi komunikasi kesehatan menjadi bagian integral dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sadar kesehatan.

Sebagai landasan praktik profesional, aspek etika dan profesionalisme tenaga kesehatan turut dibahas secara komprehensif. Nilai-nilai integritas, tanggung jawab, empati, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi pilar utama dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Profesionalisme yang kuat diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dan praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi kesehatan, serta pemangku kebijakan. Buku ini tidak hanya menggambarkan isu dan tantangan, tetapi juga menghadirkan perspektif solutif guna memperkuat peran tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7556-74-5



9

786347

556745